

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 dhoulkaâda 1436 – 8 septembre 2015

158^{ème} année

N° 72

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

- Nomination d'un directeur général 2135
- Arrêté du chef du gouvernement du 4 septembre 2015, portant organisation d'un cycle de formation au profit des cadres administratifs à l'institut de leadership administratif à l'école nationale d'administration 2135
- Arrêté du chef du gouvernement du 4 septembre 2015, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle supérieur à l'école nationale d'administration au titre de l'année 2015 2135

Ministère de l'Intérieur

- Décret gouvernemental n° 2015-1194 du 3 septembre 2015**, portant modification des limites territoriales de la commune d'El Hama du gouvernorat de Gabès 2137

Ministère de la Santé

- Décret gouvernemental n° 2015-1195 du 4 septembre 2015**, modifiant et complétant le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine 2139
- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant organisation du concours de recrutement de résidents en médecine 2140

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.....	2165
Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant ouverture d'un concours pour le recrutement des résidents en pharmacie.....	2165
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Nomination d'un directeur général	2167
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Décret gouvernemental n° 2015-1197 du 27 août 2015, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan	2167
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Nomination d'ingénieurs généraux	2172
Nomination d'ingénieurs en chef.....	2172
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Nomination du président-directeur général de l'office nationale de la télédiffusion	2175
Nomination de directeurs généraux.....	2175

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2015-1193 du 4 septembre 2015.

Monsieur Lassad Klai, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale, à la Présidence du gouvernement.

Arrêté du chef du gouvernement du 4 septembre 2015, portant organisation d'un cycle de formation au profit des cadres administratifs à l'institut de leadership administratif à l'école nationale d'administration.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration, tel que modifié par le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014 et notamment ses articles 14 (nouveau), 15 (nouveau) et 16 (nouveau),

Vu le décret n° 2007-1940 du 30 juillet 2007, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale d'administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1568 du 9 février 2009.

Arrête :

Article premier - Est organisé à l'institut de leadership administratif un cycle de formation au titre de l'année 2015, visant l'amélioration des compétences des cadres administratifs dans le domaine du management public.

Art. 2 - Le cycle de formation comprend notamment des conférences, des séminaires et des ateliers de travail.

Art. 3 - Le cycle de formation est organisé du 22 octobre 2015 jusqu'au 25 décembre 2015.

Art. 4 - Les activités programmées dans le cadre du cycle de formation susvisé sont organisées au profit des cadres administratifs qui occupent la fonction de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente.

Le cycle de formation est sanctionné, le cas échéant, par l'obtention d'une attestation de participation.

Art. 5 - Le programme du cycle de formation ainsi que les modalités pratiques d'organisation, de suivi et d'évaluation sont fixés par décision du directeur de l'école nationale d'administration en coordination avec les services concernés de la Présidence du gouvernement.

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 septembre 2015.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du chef du gouvernement du 4 septembre 2015, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle supérieur à l'école nationale d'administration au titre de l'année 2015.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réorganisation de l'école nationale d'administration, telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986, relative à la loi de finances rectificative pour la gestion 1986,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée ou complétée et notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, portant statut particulier des conseillers des services publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieur, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007 et le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1^{er} août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système « LMD »,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel que modifié par l'arrêté du 1^{er} mars 2010 et l'arrêté du chef du gouvernement du 4 septembre 2012.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'école nationale d'administration, un concours sur épreuves pour l'entrée au cycle supérieur aux candidats titulaires :

- des diplômes nationaux de mastères au moins dans les sciences à caractère économique ou de gestion, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- des diplômes nationaux de mastères au moins dans les sciences à caractère juridique ou politique, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- des diplômes nationaux d'ingénieurs ou les diplômes équivalents dans les spécialités suivantes:

- génie industriel,

- génie civil,

- génie énergétique,

- informatique,

- statistique et analyse de l'information,

- télécommunications,

- hydrométéorologie,

- le diplôme national d'ingénieur délivré par l'école polytechnique de Tunis,

- le diplôme national d'architecte.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites du concours aura lieu le 29 octobre 2015 et jours suivants.

Art. 3 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à cinquante (50) postes répartis comme suit :

- 22 postes dans la spécialité des sciences à caractère économique ou de gestion,
- 18 postes dans la spécialité des sciences à caractère juridique ou politique,
- 10 postes aux titulaires du diplôme national d'ingénieur dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté.

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 1^{er} octobre 2015 inclus.

Art. 5 - Les candidats au concours doivent s'inscrire à distance via le site internet de l'école www.concours-ena.nat.tn. Ils doivent ensuite et dans un délai ne dépassant pas la date de clôture de la liste des candidatures, présenter leurs candidatures au siège de l'école contre un récépissé délivré à cet effet ou l'envoyer par voie recommandée avec accusé de réception à l'école nationale d'administration : 24, avenue du docteur Calmette-Mutuelle Ville Tunis 1082.

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 septembre 2015.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret gouvernemental n° 2015-1194 du 3 septembre 2015, portant modification des limites territoriales de la commune d'El Hamma du gouvernorat de Gabès.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment son article 5,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative à la loi de finances 2014,

Vu le décret du 20 août 1920, portant création de la commune d'El Hamma,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération de la délégation spéciale de la commune d'El Hamma en date du 10 mai 2013,

Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Gabès en date du 20 mai 2013,

Vu l'avis du gouverneur de Gabès,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées, les limites territoriales de la commune d'El Hamma suivant la ligne polygonale fermée (A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - A1 - B1 - C1 - D1 - E1 - F1 - G1 - A) marquée en couleur violet sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

- du point "A" situé aux coordonnées (X=3021.44/Y=5804.38) passant par les points "B" Situé aux coordonnées (X=3117.65/Y= 5819.30), "C" situé aux coordonnées (X=3113.82/Y=5843.99), "D" Situé aux coordonnées (X=3212.64/Y=5859.31), "E" situé aux coordonnées (X=3216.47/Y=5834.62) et "F" situé aux coordonnées (X=4159.67/Y=5978.07) en suivant la rocade d'El Hamma en arrivant au point "G" situé aux coordonnées (X= 6662.86/Y= 4453.81),

- du point "G" la limite dévie vers l'Est sur une distance de 2006 mètres environ jusqu'au point "H" situé aux (X=8569.44/Y=5078.12),

- du point "H" la limite s'oriente vers le Sud sur une distance de 1149 mètres environ jusqu'au point "I" situé aux coordonnées (X= 8667.24/Y=3933.73),

- du point "I" la limite se dirige vers l'Ouest sur une distance de 2791 mètres environ jusqu'au point "J" situé aux coordonnées (X=5964.46/Y=3238.06),

- du point "J" la limite dévie vers le Sud sur une distance de 2700 mètres environ vers le point "K" situé aux coordonnées (X=4723.83/Y=840.20),

- du point "K" la limite se dirige vers l'Est sur une distance de 737 mètres environ jusqu'au point "L" situé aux coordonnées (X=5398.8/Y=544.92),

- du point "L" la limite se dirige vers le Sud sur une distance de 628 mètres environ en traversant la route menant d'EL Hamma à Matmata jusqu'au point "M" situé aux coordonnées (X=5245.25/Y= - 63.77),

- du point "M" la limite se dirige vers l'Ouest sur une distance de 1853 mètres environ jusqu'au point "N" situé aux coordonnées (X=3391.81/Y= - 62.75),

- du point "N" la limite se dérive vers le Sud sur une distance de 532 mètres environ suivant la piste se SEREPT jusqu'au point "O" situé aux coordonnées (X=3243.69/Y= - 359.81),

- du point "O" la limite se dirige vers Nord-Ouest sur une distance de 1150 mètres environ jusqu'au point "P" situé aux coordonnées (X=2911.74/Y=741.61),

- du point "P" la limite se dirige vers l'Ouest sur une distance de 1187 mètres environ jusqu'au point "Q" situé aux coordonnées (X=1799.94/Y=325.82),

- du point "Q" la limite suit la rive droite d'Oued El Hamma en passant par les points "R" situé aux coordonnées (X=1734.22/Y=545.84), "S" situé aux coordonnées (X=1703.28/Y=556.39), "T" situé aux coordonnées (X=1327.05/Y=946.33), "U" situé aux coordonnées (X=1343.6/Y=1046.64), "V" situé aux coordonnées (X=1133.33/Y=1334.92), "W" situé aux coordonnées (X=818.64/Y= 1533.54) et "X" situé aux coordonnées (X=463.22/Y=1662.89) en arrivant au point "Y" situé aux coordonnées (X=350.89/Y=1764.33),

- du point "Y" la limite dérive vers l'Ouest sur une distance de 179 mètres environ en traversant Oued El Hamma et arrivant au point "Z" situé à aux coordonnées (X=175.38/Y=1729.92),

- du point "Z" la limite suit la même direction sur une distance de 948 mètres environ jusqu'au point "A1" situé aux coordonnées (X=- 471.89/Y=1759.03),

- du point "A1" la limite se dirige vers le Nord sur une distance de 602 mètres environ, en traversant la route nationale n° 16 et en arrivant au point "B1" situé aux coordonnées (X= -469.35/Y= 2360.26),

- du point "B1" la limite se dérive vers le Nord Est sur une distance de 1181 mètres environ passant par le point "C1" situé aux coordonnées (X=183.11/Y=2724.18) et en arrivant au point "D1" situé aux coordonnées (X=670.30/Y=2942.89),

- du point "D1" la limite se dirige vers le Sud Est sur une distance de 1398 mètres environ en arrivant au point "E1" au coordonnées (X=1848.96/Y=2190.55),

- du point "E1" la limite se dirige vers le Nord Est sur une distance de 1192 mètres environ en arrivant au point "F1" situé aux coordonnées (X=2965.96/Y=2607.82),

- du point "F1" la limite se dirige vers le Nord sur une distance de 3197 mètres environ passant par le point "G1" situé aux coordonnées (X=3029.10/Y=5754.97) et en arrivant au point "A" point de départ.

Art. 2 - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, la municipalité d'El Hamma devra marquer sur le terrain tous les points prévus par l'article premier du présent décret gouvernemental par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de la commune d'El Hamma devra afficher à l'entrée du siège de la commune une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 septembre 2015.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

*Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur*

**Mohamed Najem
Gharsalli**

Décret gouvernemental n° 2015-1195 du 4 septembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut des stagiaires internés et des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2315 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, portant statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 15 (alinéa 3), 21 (1^{er} tiret), 25, 31 et 40 du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 15 (alinéa 3 nouveau) - Aucun crédit ne peut être accordé lors du passage du deuxième au troisième cycle des études médicales.

Article 21 (1^{er} tiret nouveau) :

- ayant opté d'emblée pour la médecine de famille dès la fin de la troisième année du deuxième cycle (D.C.E.M 3) selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 25 (nouveau) - Les facultés de médecine délivrent le diplôme national de docteur en médecine aux étudiants qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

1- ayant réussi aux examens du deuxième cycle et validé l'ensemble des stages de ce cycle,

2- ayant réussi aux examens cliniques,

3- ayant obtenu l'attestation d'habilitation à l'exercice de la médecine de famille octroyé par le collège national de médecine de famille ou ayant accompli et validé un cycle complet de résidanat conformément aux dispositions de l'article 37 du présent décret gouvernemental,

4- ayant soutenu avec succès leurs thèses.

Article 31 (nouveau) - Le résidanat en médecine est ouvert aux :

1- étudiants inscrits aux facultés de médecine tunisiennes et ayant accompli avec succès la troisième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.3) et ne s'étant pas inscrits au troisième cycle des études médicales,

2- docteurs en médecine qu'ils soient tunisiens ou étrangers à condition qu'ils justifient de l'exercice de la médecine pendant cinq (5) ans au moins,

3- médecins de la santé publique dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret gouvernemental.

Article 40 (nouveau) - Les facultés de médecine tunisiennes délivrent le diplôme de médecin spécialiste aux résidents en médecine ayant effectué un cycle complet de résidanat, tel que prévu par l'article 37 du présent décret gouvernemental et ayant subi avec succès l'examen national de spécialité sur épreuves pratiques et écrites.

Les candidats audit examen doivent être titulaires du diplôme national de docteur en médecine.

Art. 2 - Est supprimée l'expression « médecine d'urgence » prévue au paragraphe (3) de l'article 33 du présent décret gouvernemental intitulé « Biologie et disciplines fondamentales ».

Il est ajouté à la liste des spécialités médicales prévue au paragraphe (1) de l'article 33 du présent décret gouvernemental intitulé « médecine et spécialités médicales » la spécialité suivante : « médecine d'urgence ».

Art. 3 - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 susvisé, les articles 31 (bis), 33 (bis) et un deuxième alinéa à l'article 34, libellés comme suit :

Article 31 (bis) - Tout étudiant ayant réussi au concours de résidanat doit s'inscrire à la faculté de médecine dans laquelle il a accompli son deuxième cycle des études médicales ou celle du lieu de résidence pour le candidat diplômé d'une faculté de médecine étrangère.

L'inscription est annuelle. Chaque résident est tenu de renouveler annuellement son inscription durant le cursus du résidanat.

Article 33 (bis) - Le choix de la spécialité se fait selon l'ordre de mérite parmi les spécialités ouvertes au concours et ce dans la limite du nombre de postes à concourir par spécialité. Le choix de la spécialité est définitif et non susceptible de changement.

Article 34 (alinéa 2) - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, pour les candidats ayant réussi au concours et n'ayant pas validé leurs stages de la quatrième année du deuxième cycle des études médicales ou ayant encore un crédit, leur prise de fonctions est reportée au mois de janvier de l'année suivant la régularisation de leur situation.

Art. 4 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 septembre 2015.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Pour Contreseing

Le ministre de la santé

Saïd Aïdi

Le ministre de

l'enseignement supérieur

et de la recherche

scientifique

Chiheb Bouden

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant organisation du concours de recrutement de résidents en médecine.

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 et notamment son article 33,

Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine, tel que modifié par le décret n° 2015-1195 du 4 septembre 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 23 septembre 1993, portant organisation du concours pour le recrutement de résidents en médecine, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 26 juin 2000.

Arrêtent :

Article premier - Est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté le concours de recrutement de résidents en médecine pour les services hospitaliers et les départements des facultés de médecine de Tunisie.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours, les lieux et la date d'ouverture du concours ainsi que la date de clôture du registre d'inscription des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 3 - Le concours visé à l'article premier du présent arrêté, est ouvert aux :

1- étudiants inscrits aux facultés de médecine tunisiennes et ayant accompli avec succès la troisième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.3) et ne s'étant pas inscrits au troisième cycle des études médicales.

2- Docteurs en médecine tunisiens ou étrangers ayant exercé la médecine pendant au moins cinq (5) ans,

3- Médecins de la santé publique dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 susvisé.

Art. 4 - Le dépôt de la demande d'inscription au concours se fait auprès de la faculté de médecine tunisienne où le candidat était inscrit au deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.) ou celle du lieu de résidence pour le candidat diplômé d'une faculté de médecine étrangère.

Art. 5 - Il est créé une commission nationale du résidanat en médecine chargée, notamment, de l'organisation et du déroulement pédagogique du concours de résidanat en médecine et de la validation définitive des candidatures.

Ladite commission est composée comme suit :

Président : le directeur général de la santé.

Vice-président : un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Membres :

- * les doyens des facultés de médecine ou leurs représentants,

- * le président du bureau national des spécialités médicales ou son représentant,

- * le directeur général des services communs du ministère de la santé ou son représentant.

Art. 6 - La commission nationale du résidanat en médecine est assistée par une sous-commission pédagogique et une sous-commission administrative.

Art. 7 - La sous-commission pédagogique est composée de trois (3) professeurs ou maîtres de conférences agrégés par faculté de médecine et d'un président coordinateur. Elle a pour missions notamment :

- * de contribuer avec les enseignants des facultés de médecine à la production des questions et à leur validation,

- * d'organiser et de superviser la banque de questions,

- * d'établir les recommandations pédagogiques concernant la confection des épreuves,

- * d'apporter le soutien pédagogique au jury du concours,

- * d'encadrer l'éventuelle révision des sujets du concours et de leurs objectifs.

Art. 8 - La sous-commission administrative est composée du directeur général des services communs du ministère de la santé ou son représentant et des secrétaires généraux des facultés de médecine. Elle a pour missions notamment :

- * d'organiser et de suivre les inscriptions des candidats au concours,

- * d'apporter le soutien logistique pour assurer le bon déroulement du concours,

- * de vérifier la recevabilité des candidatures.

La liste des candidatures est soumise par la sous-commission administrative à la commission nationale du résidanat en médecine, pour la validation définitive des candidatures.

Art. 9 - Les membres de la sous-commission pédagogique sont désignés par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission nationale du résidanat en médecine, et ce, pour une durée de trois (3) ans renouvelables.

Art. 10 - Le concours de résidanat en médecine comporte deux épreuves écrites qui portent sur des sujets comportant chacun des objectifs spécifiques intégrant les aspects cliniques, fondamentales et mixtes et de santé publique.

Chaque épreuve dure deux heures trente minutes (2 heure 30 min).

Les deux épreuves portent respectivement sur les sujets des listes 1 et 2 de sujets, prévues en annexe jointe au présent arrêté.

Les sujets et/ou leurs objectifs peuvent être révisées chaque deux (2) ans au moins sans dépasser les dix pour cent (10%) de l'ensemble des sujets.

Chaque épreuve comporte des questions de vérification des connaissances et des questions de résolution de problème sous forme de questions à choix multiples (QCM) et de questions à réponses ouvertes et courtes (QROC) et de cas cliniques, dans les domaines cliniques, fondamentales et mixtes et de santé publique.

Le jury du concours veille à ce que les questions se rapportant à chaque épreuve portent sur la majorité des sujets de chaque liste.

Les deux épreuves susvisées, ont le même coefficient.

Art. 11 - Les épreuves sont jugées par le jury du concours visé à l'article 10, qui est désigné par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le jury du concours comprend, outre son président :

- * vingt quatre (24) membres titulaires au moins représentant les quatre facultés de médecine et huit (8) membres suppléants tirés au sort par la commission nationale du résidanat en médecine, parmi les professeurs et les maîtres de conférences agrégés des facultés de médecine tunisiennes,

* au moins quatre (4) membres de la sous-commission pédagogique représentant les quatre facultés de médecine, désignés par la commission nationale du résidanat en médecine.

La composition des membres du jury doit être multidisciplinaire (spécialités médicales, chirurgicales, fondamentales et mixtes) pour assurer l'expertise nécessaire pour la validation des questions et des réponses.

Art. 12 - Le score de chaque épreuve est rapporté à une note sur vingt.

L'admission au concours dans la limite du nombre de postes ouverts, est conditionnée par la moyenne des notes du candidat aux deux épreuves, qui doit être égale à au moins dix (10) sur vingt (20).

Toute note inférieure à huit sur vingt à l'une des deux épreuves est éliminatoire.

Art. 13 - Le jury établit par ordre de mérite une liste commune des candidats tunisiens, de toutes catégories.

Il déclare admis parmi cette liste les candidats tunisiens de toutes catégories ayant les meilleures moyennes sans note éliminatoire, dans la limite de l'ensemble des postes ouverts.

Si le nombre des admis parmi les médecins de la santé publique dépasse les dix pour cent (10%) de l'ensemble des postes ouverts, les médecins de la santé publique retenus au-delà de ce pourcentage sont considérés admis en dehors du cadre de la formation continue.

Les candidats de nationalité étrangère ayant obtenu une moyenne égale au moins à celle du dernier des candidats tunisiens déclarés admis et n'ayant pas de note éliminatoire, peuvent être nommés en surnombre dans une limite de dix pour cent (10%) de l'ensemble des postes ouverts.

En cas d'ex-aequo, le classement des candidats se fera sur la base de la note relative aux questions portant sur les cas cliniques, qui départage les ex-aequo.

Art. 14 - La prise de fonction en qualité de résident des candidats admis au concours est tributaire de :

* la validation de l'ensemble de leurs stages de la quatrième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.4) et de l'absence de crédit.

* l'inscription à la faculté de médecine tunisienne où le candidat était inscrit au deuxième cycle ou celle du lieu de résidence pour le candidat diplômé d'une faculté de médecine étrangère.

Art. 15 - Les candidats admis au concours doivent, préalablement à leur première prise de fonctions, procéder au choix de la spécialité en fonction de leur classement et des postes ouverts dans chaque spécialité.

Le choix de la spécialité est définitif et non susceptible de changement.

Les candidats admis au concours n'ayant pas procédé au choix de la spécialité aux dates fixées à cet effet perdent le bénéfice de leur admission au concours sans être remplacés.

Le choix des stages dans les services hospitaliers est effectué par les résidents en fonction de leur ancienneté et de leur classement dans le résultat du concours, compte tenu des cursus des spécialités.

Art. 16 - Les postes mis en concours sont ouverts parmi les spécialités prévues par l'article 33 du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, susvisé.

Art. 17 - Pour les années 2015 et 2016, il sera ouvert deux concours de résidanat en médecine ainsi qu'il suit :

* un concours selon les dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1993, susvisé, pour les promotions d'étudiants en médecine ayant accompli avec succès la troisième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.3) avant l'année 2015 et ayant validé l'année de leur stage interné,

* un concours selon les dispositions du présent arrêté, pour les étudiants des facultés tunisiennes ayant accompli avec succès la troisième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.3) à partir de l'année 2015.

A partir de l'année 2017, les candidats des facultés tunisiennes, ayant accompli avec succès la troisième année du deuxième cycle (D.C.E.M.3) des études médicales avant l'année 2015 et ayant validé leur stage interné, participent au concours de recrutement des résidents en médecine, selon les dispositions du présent arrêté.

Art. 18 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de la santé du 23 septembre 1993, susvisé, et ce, progressivement et jusqu'à une durée n'excédant pas l'année 2016.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 septembre 2015.

Le ministre de la santé

Saïd Aïdi

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Chiheb Bouden

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Programme du concours de résidanat en médecine

Liste 1 de l'épreuve 1 : sujets numéro 1 à 38.

Liste 2 de l'épreuve 2 : sujets numéro 39 à 75.

1. Accidents vasculaires cérébraux. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire la vascularisation artérielle et veineuse de l'encéphale.
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques.
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral.
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique.
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique.
6. Etablir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique à partir des données cliniques et radiologiques.
7. Etablir le diagnostic topographique de la thrombose veineuse cérébrale à partir des données cliniques et radiologiques.
8. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique selon l'âge.
9. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique.
10. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémique et hémorragique.

2. Adénopathies superficielles. Orientation diagnostique.

1. Définir une adénopathie superficielle.
2. Reconnaître par l'interrogatoire et l'examen physique, les caractéristiques cliniques d'une adénopathie superficielle.
3. Différencier par l'examen clinique, une adénopathie superficielle d'une tuméfaction non ganglionnaire dans la région axillaire, cervicale et inguinale.
4. Reconnaître par les données de l'examen clinique, les caractéristiques orientant vers une origine maligne d'une adénopathie superficielle.
5. Hiérarchiser les examens complémentaires en fonction des données de l'examen clinique chez un patient présentant une adénopathie superficielle.
6. Etablir par l'examen clinique et les examens complémentaires le diagnostic étiologique d'une adénopathie superficielle.

3. Anémies. Physiopathologie, Diagnostic, traitement.

1. Etablir le diagnostic positif d'une anémie à partir des données anamnestiques, cliniques et biologiques en tenant compte de l'âge, du sexe et de l'état physiologique du patient.
2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques d'une anémie d'origine centrale ou périphérique.
3. Décrire le métabolisme du fer, des cobalamines et des folates.
4. Classer une anémie à partir des constantes érythrocytaires et de la numération des réticulocytes.
5. Etablir la démarche du diagnostic étiologique d'une anémie en fonction des données anamnestiques, cliniques et biologiques.
6. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une anémie selon sa gravité et son étiologie.
7. Etablir une stratégie préventive devant une anémie en fonction de son origine.

4. Appendicite aiguë, Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques

1. Enumérer les variations anatomiques de l'appendice et ses rapports anatomiques.
2. Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des appendicites aiguës.
3. Décrire les différents aspects anatomo-pathologiques des appendicites aiguës selon leurs modes évolutifs.
4. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de poser le diagnostic positif d'appendicite aiguë dans ses diverses formes cliniques.
5. Eliminer sur les données cliniques et paracliniques les principaux diagnostics différentiels des appendicites aiguës dans leurs différentes formes cliniques.
6. Exposer les principes du traitement de l'appendicite aiguë et ses indications.

5. Arrêt cardio-circulatoire. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire les différentes phases du potentiel d'action au niveau du tissu nodal et du myocarde et sa régulation nerveuse.
2. Décrire les différentes étapes de réalisation et l'aspect normal d'un électrocardiogramme.
3. Expliquer les conséquences des modifications tissulaires et métaboliques de l'anoxie par arrêt circulatoire.
4. Etablir le diagnostic positif et étiologique d'un arrêt circulatoire.
5. Reconnaître les différents signes électrocardiographiques au cours de l'arrêt cardio-circulatoire.
6. Décrire les différents éléments de la chaîne de survie.
7. Planifier la prise en charge thérapeutique d'un arrêt cardio-circulatoire.
8. Décrire les modalités de mise en place des différents actes thérapeutiques utilisés dans la prise en charge d'un arrêt cardio-circulatoire.
9. Décrire le mécanisme d'action et les principales propriétés pharmacocinétiques des différents médicaments utilisés dans le traitement de l'arrêt cardio-circulatoire.
10. Planifier la prise en charge d'un arrêt circulatoire chez un nouveau-né en salle de naissance.

6. Arthrite septique. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire les mécanismes étiopathogéniques d'une arthrite septique (AS).
2. Expliquer les conséquences physiopathologiques d'une AS.
3. Réunir les arguments cliniques et paracliniques en faveur d'une AS dans ses différentes formes cliniques.
4. Confirmer le diagnostic de l'arthrite septique.
5. Interpréter les résultats d'une ponction articulaire.
6. Apprécier par des éléments cliniques et paracliniques la gravité locale et générale d'une AS.
7. Enumérer les séquelles d'une arthrite septique.
8. Enumérer les diagnostics différentiels des arthrites septiques.
9. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une arthrite septique.

7. Asthme de l'adulte et de l'enfant. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Formes graves, Traitement.

1. Décrire le mécanisme étiopathogénique de l'asthme allergique.
2. Expliquer les mécanismes de régulation nerveuse et humorale de la bronchomotricité.
3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'obstruction bronchique dans l'asthme.
4. Définir l'asthme de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.
5. Réunir les éléments de l'anamnèse et de l'examen physique en faveur du diagnostic positif de l'asthme en fonction de l'âge.
6. Réunir les données paracliniques en faveur du diagnostic positif d'asthme chez l'enfant et l'adulte.
7. Réunir les arguments cliniques et paracliniques en faveur de l'étiologie allergique d'un asthme.
8. Reconnaître, sur des arguments cliniques et paracliniques, les différentes étiologies de l'asthme selon l'âge, en dehors de l'allergie
9. Reconnaître une crise d'asthme sur les éléments cliniques.
10. Réunir les éléments permettant de classer la sévérité de la crise d'asthme.
11. Citer les principaux facteurs de risque d'un asthme aigu grave.
12. Réunir les arguments cliniques et paracliniques en faveur d'un asthme aigu grave en fonction de l'âge.
13. Citer les principaux diagnostics différentiels de l'asthme selon l'âge.
14. Evaluer le contrôle de l'asthme selon les recommandations internationales.
15. Décrire le mécanisme d'action et les effets indésirables des différentes classes médicamenteuses utilisées dans le traitement de l'asthme.
16. Planifier le traitement de la crise d'asthme en fonction de sa sévérité chez l'enfant et l'adulte.
17. Planifier le traitement de fond de l'asthme en fonction de sa sévérité et de son contrôle chez l'enfant et l'adulte.
18. Etablir les principes de l'éducation thérapeutique de l'asthme.
19. Indiquer les moyens de prévention de l'asthme allergique.

8. Bronchiolites du nourrisson. Diagnostic, traitement.

1. Définir une bronchiolite du nourrisson.
2. Citer les principaux virus responsables de la bronchiolite du nourrisson. .
3. Etablir le diagnostic positif d'une bronchiolite du nourrisson à partir des données de l'anamnèse, de l'examen physique et de la radiographie du thorax.
4. Reconnaître sur les données de l'examen clinique et des examens complémentaires les critères d'hospitalisation d'une bronchiolite du nourrisson.
5. Identifier par l'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires, les critères de gravité d'une bronchiolite du nourrisson.
6. Distinguer une bronchiolite des autres causes de dyspnée aiguë du nourrisson.
7. Décrire les principes de la prise en charge thérapeutique d'un nourrisson présentant une bronchiolite.
8. Citer les complications aiguës de la bronchiolite du nourrisson.
9. Décrire les moyens de prévention de la bronchiolite du nourrisson.

9. Bronchopneumopathies chroniques obstructives. Etiopathogénie, Diagnostic, traitement.

1. Définir la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
2. Décrire les deux systèmes mécaniques respiratoires.
3. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de la BPCO en Tunisie.
4. Identifier les facteurs de risque de la BPCO.
5. Décrire les différents mécanismes de l'obstruction bronchique dans la BPCO.
6. Décrire les perturbations de la mécanique respiratoire et des échanges gazeux au cours de la BPCO et de l'emphysème.
7. Réunir les éléments cliniques et fonctionnels en faveur du diagnostic positif d'une BPCO.
8. Décrire la sévérité de la BPCO selon les dernières recommandations internationales.
9. Enumérer les comorbidités les plus fréquentes chez un patient ayant une BPCO.
10. Décrire les tableaux phénotypiques associés à la BPCO.
11. Citer les complications aiguës et chroniques de la BPCO.
12. Identifier une exacerbation de BPCO, en évaluant ses signes de gravité.
13. Identifier les signes spirométriques permettant de distinguer la BPCO de l'asthme.
14. Planifier la stratégie de traitement de l'exacerbation d'une BPCO.
15. Planifier la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse de la BPCO à l'état stable.
16. Indiquer les moyens de prévention de la BPCO.

10. Brûlures cutanées récentes. Physiopathologie, Prise en charge initiale.

1. Expliquer les mécanismes et les conséquences physiopathologiques des brûlures en fonctions des différents agents vulnérants et du terrain.
2. Réunir les éléments qui conditionnent le pronostic vital et fonctionnel d'un brûlé grave.
3. Organiser la prise en charge thérapeutique initiale des brûlures récentes en fonction du siège de l'agent causal et de la gravité.
4. Planifier la surveillance d'un brûlé,

11. Cancer broncho-pulmonaire. Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations Thérapeutiques.

1. Reconnaître, à partir de l'anatomie topographique du médiastin et des fosses pleuropulmonaires, les bases anatomiques de l'extension locorégionale du cancer broncho-pulmonaire.
2. Décrire la situation épidémiologique du cancer broncho-pulmonaire dans le monde et en Tunisie.
3. Citer les principaux facteurs incriminés dans la genèse des cancers broncho-pulmonaires primitifs.
4. Citer les principales formes anatomopathologiques du cancer broncho-pulmonaire primitif en précisant leur fréquence, leur topographie préférentielle et leurs particularités évolutives.
5. Décrire les différentes circonstances de découverte du cancer broncho-pulmonaire primitif.
6. Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et radiologiques permettant d'évoquer le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif.
7. Indiquer les examens complémentaires nécessaires au diagnostic positif du cancer broncho pulmonaire primitif.
8. Indiquer les examens cliniques et paracliniques nécessaires pour le bilan d'extension et la classification en stades du cancer broncho- pulmonaires primitifs.
pulmonaire primitif.
9. Reconnaître les principaux diagnostics différentiels d'un cancer broncho pulmonaire primitif sur des arguments cliniques et radiologiques.
10. Etablir le bilan pré thérapeutique du cancer broncho-pulmonaire primitif.
11. Poser les indications thérapeutiques devant un cancer broncho-pulmonaire primitif en fonction du type histologique, du terrain et de la classification TNM.
12. Planifier la prise en charge symptomatique et psychologique d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.
13. Evaluer le pronostic d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.
14. Décrire les moyens de prévention du cancer broncho-pulmonaire primitif.

12. Cancer du cavum. Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations Thérapeutiques.

1. Identifier les rapports anatomiques du cavum et ses relais de drainage lymphatique.
2. Décrire les particularités épidémiologiques du cancer du cavum.
3. Décrire les aspects anatomopathologiques du cancer du cavum.
4. Décrire les facteurs étiologiques du cancer du cavum,
5. Reconnaître à l'examen clinique les signes d'appel d'un cancer du cavum.
6. Etablir le diagnostic positif d'un cancer du cavum.
7. Etablir, à partir du bilan d'extension clinique et paraclinique la classification TNM du cancer du cavum.
8. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant d'évaluer le pronostic du cancer du cavum.
9. Préciser les moyens thérapeutiques et leurs indications dans le cancer du cavum,
10. Planifier la surveillance clinique et paraclinique d'un patient traité pour cancer du cavum.

13. Cancer du col de l'utérus, Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations Thérapeutiques.

1. Décrire la vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique de l'utérus.
2. Expliquer le rôle des papillomavirus oncogènes dans la genèse du cancer du col de l'utérus.
3. Décrire les particularités anatomo-pathologiques des lésions précancéreuses et du cancer invasif du col de l'utérus.
4. Décrire les modes d'extension du cancer du col de l'utérus.
5. Citer les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus.
6. Etablir sur des arguments cliniques et paracliniques le diagnostic positif du cancer du col de l'utérus.
7. Evaluer sur des arguments cliniques et paracliniques le pronostic du cancer du col de l'utérus.
8. Décrire les principes thérapeutiques du cancer du col de l'utérus, en fonction du stade évolutif.
9. Décrire les modalités de surveillance post-thérapeutique d'une femme porteuse d'un cancer du col de l'utérus.
10. Indiquer les moyens de prévention primaire et secondaire du cancer du col de l'utérus.

14. Cancer du sein. Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations Thérapeutiques.

1. Décrire le système drainage lymphatique du sein.
2. Décrire les particularités anatomopathologiques des tumeurs malignes du sein.
3. Expliquer le mode d'extension du cancer du sein.
4. Identifier à partir des données de l'anamnèse les sujets à risque de développer un cancer du sein.
5. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de poser le diagnostic du cancer du sein en fonction du degré d'évolution.
6. Evaluer sur des arguments cliniques et paracliniques le pronostic du cancer du sein.
7. Planifier la stratégie thérapeutique du cancer du sein en fonction du stade TNM et des facteurs histo-pronostiques.
8. Indiquer les modalités de surveillance post-thérapeutique d'un cancer du sein.
9. Elaborer la stratégie du diagnostic précoce du cancer du sein.
10. Expliquer les moyens de prévention du cancer du sein.

15. Cancers colorectaux. Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations Thérapeutiques.

1. Identifier les facteurs de risque des cancers colorectaux.
2. Planifier le dépistage des cancers colorectaux à l'échelle individuelle et communautaire en fonction des groupes à risque.
3. Décrire à partir de l'anatomie du colon et du rectum (rapports, vascularisation, drainage lymphatique) les différents modes d'extension des cancers colorectaux.
4. Citer les circonstances de découverte des cancers colorectaux.
5. Etablir le diagnostic positif des cancers colorectaux.
6. Indiquer les examens permettant d'établir le bilan d'extension d'un cancer colorectal.
7. Planifier la prise en charge thérapeutique des cancers colorectaux.
8. Enumérer les facteurs pronostics des cancers colorectaux (cliniques, radiologiques, histologiques, biologiques).
9. Décrire les méthodes et stratégies de surveillance d'un patient traité pour cancer colorectal.

16. Céphalées. Physiopathologie, Orientation Diagnostique.

1. Expliquer la physiopathologie de la migraine.
2. Etablir la démarche diagnostique (positive, différentielle et étiologique) devant une céphalée aiguë primaire et secondaire.
3. Etablir la démarche diagnostique (positive, différentielle et étiologique) devant une céphalée chronique primaire et secondaire.
4. Poser le diagnostic d'une urgence devant des céphalées.
5. Etablir, à partir des données cliniques, le diagnostic d'une migraine.
6. Etablir à partir des données cliniques, le diagnostic d'une céphalée de tension, d'une névralgie du trijumeau et d'une algie vasculaire de la face.

17. Coma. Orientations Diagnostiques.

1. Définir le coma
2. Etablir le diagnostic positif d'un coma à partir des données cliniques et paracliniques.
3. Etablir le diagnostic étiologique et différentiel d'un coma à partir des données cliniques et paracliniques.
4. Evaluer la profondeur d'un coma.
5. Préciser le retentissement viscéral d'un coma en fonction de sa profondeur.
6. Etablir le diagnostic d'une mort encéphalique à partir des données cliniques et paracliniques.

18. Contraception. Bases scientifiques, modalités pratiques.

1. Définir la contraception.
2. Décrire les différents moyens de contraception.
3. Expliquer les bases pharmacologiques de la contraception hormonale.
4. Préciser l'efficacité (indice de PEARL) des différents moyens de contraception en fonction du mode d'action.
5. Justifier le choix d'une méthode contraceptive en fonction du bilan clinique et paraclinique de la patiente.
6. Détailler les modalités de surveillance clinique et biologique d'une femme sous contraception hormonale ou mécanique.
7. Préciser les moyens et les modalités d'utilisation d'une contraception d'urgence (contraception du lendemain).

19. Déshydratations aiguës de l'enfant. Physiopathologie, Diagnostic, Thérapeutiques.

1. Définir la déshydratation aiguë de l'enfant.
2. Préciser les particularités de la composition corporelle en eau en fonction de l'âge et de la régulation hydro-électrolytique.
3. Décrire les différents mécanismes de la déshydratation.
4. Etablir le diagnostic positif d'une déshydratation en se basant sur les données de l'anamnèse et de l'examen physique.
5. Evaluer le degré de sévérité d'une déshydratation aiguë de l'enfant selon le score de l'OMS.
6. Etablir la prise en charge d'une déshydratation aiguë en fonction de sa sévérité.
7. Expliquer les mesures préventives de la déshydratation.

20. Diabète sucré. Epidémiologie, Etiopathogénie, Diagnostic, Complications, Traitement.

1. Etablir le diagnostic des troubles de la tolérance glucidique (diabète et prédiabète) selon les dernières recommandations de l'American Diabetes Association (ADA).
2. Indiquer la prévalence actuelle du diabète de type 2 en Tunisie selon les données de l'International Diabetes Federation (IDF).
3. Identifier dans une population donnée les sujets qui risquent de développer un diabète sucré en précisant les modalités du dépistage.
4. Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et paracliniques pour reconnaître les différents types de diabète sucré selon la classification de l'O.M.S.
5. Expliquer l'étiopathogénie et l'histoire naturelle du diabète en fonction de son type (Diabète de type I, Diabète de type 2, Diabète secondaire, Diabète gestationnel).
6. Décrire les conséquences physiopathologiques de l'hyperglycémie.
7. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des décompensations hyperglycémiques du diabète.
8. Etablir le diagnostic positif et étiologique d'une décompensation hyperglycémique du diabète en évaluant son degré de sévérité.
9. Planifier le traitement et la surveillance d'une décompensation hyperglycémique du diabète.
10. Identifier la gravité et les facteurs impliqués dans la survenue d'une hypoglycémie chez un diabétique.
11. Préciser le degré de sévérité d'une hypoglycémie chez un diabétique. .
12. Planifier la prévention, le traitement et la surveillance d'une hypoglycémie chez un diabétique.
13. Citer les facteurs favorisant la survenue des complications chroniques suivantes chez un diabétique: neuropathie, rétinopathie, néphropathie.
14. Reconnaître à partir des données de l'examen clinique et des examens complémentaires, les complications chroniques (neuropathie, rétinopathie, néphropathie) du diabète à leurs différents stades évolutifs en identifiant celles qui nécessitent une prise en charge thérapeutique urgente.
15. Evaluer le risque cardiovasculaire chez un diabétique selon le type du diabète.
16. Planifier la stratégie de prévention des complications chroniques et de la cardioprotection chez un malade diabétique.
17. Expliquer les mécanismes d'action des médicaments utilisés pour le traitement du diabète.
18. Définir les objectifs thérapeutiques chez un diabétique en fonction du type de diabète et du terrain du patient (âge, grossesse, tares).
19. Justifier le choix d'une stratégie thérapeutique en fonction des objectifs thérapeutiques fixés, du mode d'action des médicaments, de leurs bénéfices prouvés et de leurs risques potentiels.
20. Décrire les modalités de la surveillance du diabète et de son traitement
21. Planifier une grossesse chez une patiente diabétique.
22. Planifier le traitement et la surveillance du diabète pendant la grossesse.
23. Planifier une stratégie d'éducation thérapeutique personnalisée chez un patient diabétique.
24. Planifier la réinsertion socio-professionnelle du diabétique en fonction de son handicap.
25. Décrire les modalités de la prévention primordiale et primaire du diabète de type 2 à l'échelle individuelle et collective.

21. Diarrhées chroniques, Physiopathologie, Diagnostic.

1. Définir une diarrhée chronique.
2. Expliquer les mécanismes de l'absorption intestinale.
3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des diarrhées chroniques.
4. Etablir une démarche diagnostique permettant d'orienter au diagnostic étiologique d'une diarrhée chronique chez l'enfant et chez l'adulte.
5. Evaluer le retentissement d'une diarrhée chronique.

22. Douleurs thoraciques aiguës. Orientation Diagnostique.

1. Réunir les données cliniques et paracliniques orientant vers l'étiologie d'une douleur thoracique aiguë non traumatique.
2. Indiquer les examens complémentaires adéquats en fonction de l'orientation étiologique d'une douleur thoracique aiguë.
3. Rechercher une détresse vitale chez un patient qui se présente pour une douleur thoracique aiguë.
4. Réunir les arguments cliniques et paracliniques orientant vers les urgences cardiologiques : dissection aortique, syndrome coronarien aigu, embolie pulmonaire et péricardite aiguë.
5. Réunir les arguments cliniques et paracliniques orientant vers une étiologie respiratoire d'une douleur thoracique aiguë : pneumothorax, pneumonie et pleurésie.
6. Réunir les arguments cliniques et paracliniques orientant vers une étiologie non cardiaque et non respiratoire des douleurs thoraciques (pariétale, œsophagienne, neurologique).
7. Identifier une cause extra-thoracique devant une douleur thoracique aiguë (douleur abdominale projetée, douleur psychogène).

23. Dyslipidémies. Epidémiologie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Indiquer la prévalence globale des dyslipidémies et leur part dans la morbi-mortalité cardiovasculaire.
2. Indiquer la fréquence des hyperlipoprotéïnémies familiales.
3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques, génétiques et environnementaux des hyperlipoprotéïnémies.
4. Expliquer les conséquences physiopathologiques vasculaires et extravasculaires des dyslipidémies.
5. Identifier les sujets à risque nécessitant le dépistage d'une hyperlipidémie.
6. Planifier l'exploration d'une anomalie lipidique.
7. Interpréter les résultats d'un bilan lipidique.
8. Préciser à partir des données cliniques et paracliniques le type d'une hyperlipoprotéïnémie selon la classification de Fredrickson ainsi que son risque évolutif.
9. Réunir les arguments cliniques et paracliniques en faveur d'une hyperlipoprotéïnémie secondaire.
10. Identifier les éléments du syndrome métabolique (selon les critères actualisés de l'International Diabète Fédération) chez un patient présentant une dyslipidémie.
11. Décrire le mode de transmission d'une hyperlipoprotéïnémie familiale en vue d'établir un conseil génétique.
12. Evaluer le risque vasculaire chez un patient présentant une dyslipidémie.
13. Reconnaître chez un malade dyslipidémique les complications vasculaires et extravasculaires.
14. Prescrire les mesures hygiéno-diététiques selon le type d'hyperlipoprotéïnémie.
15. Expliquer le mécanisme d'action des médicaments hypolipémiants (statines et fibrates).
16. Planifier la stratégie thérapeutique d'une hyperlipoprotéïnémie primitive ou secondaire selon les recommandations de la Société Européenne de Cardiologie.
17. Planifier la surveillance au long cours d'un patient ayant une dyslipidémie.
18. Planifier une stratégie de prévention primaire des maladies cardiovasculaires (consommation de sucre, sel et lipides, tabac, activité physique...).

24. Dysphagies. Orientation diagnostique.

1. Décrire l'anatomie morphologique de l'œsophage et les correspondances endoscopiques.
2. Décrire les éléments anatomiques définissant le sphincter inférieur de l'œsophage.
3. Réunir les éléments anamnestiques caractérisant une dysphagie (organique ou fonctionnelle).
4. Identifier les différentes étiologies d'une dysphagie.
5. Planifier la stratégie d'explorations d'une dysphagie en fonction des orientations étiologiques.

25. Endocardites infectieuses. Physiopathologie, Diagnostic, Prévention, Traitement.

1. Définir l'endocardite infectieuse.
2. Décrire les lésions anatomopathologiques observées dans l'endocardite infectieuse et leurs conséquences cliniques.
3. Expliquer l'étiopathogénie de l'endocardite infectieuse.
4. Décrire les facteurs favorisant la survenue d'une endocardite infectieuse.
5. Enumérer les principaux agents infectieux responsables des endocardites infectieuses en fonction du terrain et de la porte d'entrée.
6. Planifier les examens complémentaires utiles au diagnostic d'une endocardite infectieuse.
7. Etablir le diagnostic d'une endocardite infectieuse à partir des données de l'examen clinique et paraclinique.
8. Identifier les différentes formes cliniques des endocardites infectieuses selon le germe, le terrain et la porte d'entrée.
9. Reconnaître à partir des données cliniques et paracliniques les complications d'une endocardite infectieuse.
10. Planifier le traitement curatif et préventif de l'endocardite infectieuse.
11. Identifier les facteurs pronostics d'une endocardite infectieuse.

26. Epilepsies. Diagnostic, traitement.

1. Définir une crise épileptique et une épilepsie (selon la dernière définition de l'International League Against Epilepsy).
2. Etablir la classification des crises épileptiques et des épilepsies selon la dernière définition de l'International League Against Epilepsy.
3. Etablir la démarche diagnostique (positive, différentielle et étiologique) devant une épilepsie généralisée et focale.
4. Décrire la sémiologie électro-clinique des crises épileptiques généralisées et focales selon l'âge.
5. Reconnaître les symptômes électro-cliniques des syndromes épileptiques de l'enfant les plus fréquents : (l'épilepsie absence de l'enfant, l'épilepsie avec pointes centro-temporales et le syndrome de West).
6. Reconnaître les symptômes électro-cliniques des syndromes épileptiques de l'adolescent les plus fréquents. (épilepsie myoclonique juvénile).
7. Prescrire le traitement d'urgence de première intention visant à arrêter une crise épileptique chez l'enfant.
8. Planifier la stratégie thérapeutique devant une épilepsie selon l'âge, le terrain et le type de l'épilepsie.
9. Décrire les modalités de surveillance clinique et paraclinique ainsi que les modalités éducationnelles du suivi d'un traitement anti épileptique.
10. Planifier la prise en charge immédiate d'un état de mal épileptique.
11. Etablir la stratégie de prise en charge d'un enfant présentant une crise fébrile.
12. Décrire les principaux médicaments antiépileptiques, leurs règles de prescription, leurs effets indésirables (fréquence et gravité) et leurs interactions médicamenteuses (mécanismes et risques).

27. Etat de choc cardiogénique. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Définir un état de choc cardiogénique.
2. Expliquer la régulation intrinsèque et extrinsèque du débit cardiaque.
3. Expliquer les mécanismes et les conséquences physiopathologiques d'un état de choc cardiogénique.
4. Etablir le diagnostic (positif, étiologique et différentiel) d'un état de choc cardiogénique à partir des données anamnestiques, cliniques et para cliniques.
5. Décrire les mécanismes d'action des inotropes positifs et leurs effets hémodynamiques.
6. Planifier la prise en charge thérapeutique symptomatique et étiologique d'un état de choc cardiogénique.

28. Etat de choc hémorragique. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Etablir le diagnostic positif d'un état de choc hémorragique à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
2. Expliquer les mécanismes physiologiques de compensation mises en jeu lors d'un état choc hémorragique.
3. Décrire les conséquences microcirculatoires et viscérales d'un état de choc hémorragique.
4. Réunir les éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant d'établir le diagnostic étiologique d'un état de choc hémorragique.
5. Planifier la prise en charge thérapeutique symptomatiques et étiologique d'un état de choc hémorragique.
6. Organiser la surveillance d'un patient en état de choc hémorragique.

29. Etats confusionnels. Orientation Diagnostique.

1. Définir l'état confusionnel.
2. Etablir à partir des données anamnestiques et cliniques le diagnostic positif d'un état confusionnel.
3. Etablir à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques le diagnostic étiologique d'un état confusionnel.
4. Décrire les modalités évolutives et les complications d'un état confusionnel.

30. Etats septiques graves. Classification, Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Identifier à partir des données de l'examen clinique et des examens complémentaires les différents stades des états septiques.
2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des états septiques graves.
3. Décrire les conséquences microcirculatoire et macro-circulatoires d'un état septique grave.
4. Réunir les données anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant le diagnostic étiologique d'un état septique grave.
5. Réunir les arguments qui orientent vers l'origine communautaire ou nosocomiale d'un état septique grave.
6. Planifier la prise en charge thérapeutique des états septiques graves.
7. Organiser la surveillance d'un état septique grave.

31. Fractures ouvertes de la jambe. Physiopathologie, Diagnostic Orientations thérapeutiques.

1. Décrire l'anatomie topographique de la jambe.
2. Décrire les étapes de la consolidation osseuse.
3. Décrire les différentes lésions anatomo-pathologiques d'une fracture ouverte de la jambe.
4. Identifier à partir des données de l'examen clinique, les complications immédiates d'une fracture ouverte de la jambe.
5. Décrire les complications secondaires et tardives des fractures ouvertes de la jambe.
6. Planifier la prise en charge thérapeutique urgente d'une fracture ouverte de jambe chez l'adulte, suivant le type d'ouverture cutanée selon la classification de Cauchoux et Mechelany.
7. Préciser les objectifs et les moyens de la rééducation fonctionnelle en fonction des délais d'appui.

32. Grossesse extra-utérine. Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Définir la grossesse extra-utérine (GEU).
2. Enumérer les facteurs de risque de la GEU.
3. Décrire les différentes localisations et les modalités évolutives de la GEU.
4. Réunir les éléments cliniques et paracliniques nécessaires pour poser le diagnostic d'une GEU dans ses différentes formes cliniques.
5. Evoquer les diagnostics différentiels de la GEU.
6. Préciser les modalités thérapeutiques chirurgicales et médicales de la GEU.
7. Poser les indications thérapeutiques médicales et chirurgicales en fonction des aspects anatomo-cliniques de la GEU.

33. Hématuries. Physiopathologie, Orientations, Diagnostique, Traitement dans les situations d'urgence.

1. Définir l'hématurie macroscopique et l'hématurie microscopique.
2. Distinguer une hématurie d'une coloration anormale des urines d'une autre origine.
3. Enumérer les éléments cliniques et biologiques permettant d'évaluer le retentissement d'une hématurie ainsi que le degré de sa gravité.
4. Suspecter l'origine d'une hématurie selon son caractère initial, terminal ou total lors de la miction.
5. Distinguer l'origine urologique d'une origine néphrologique d'une hématurie à partir des données cliniques et biologiques.
6. Planifier les explorations radiologiques et endoscopiques en cas d'hématurie.
7. Expliquer l'intérêt de l'exploration du système complémentaire au cours des hématuries.
8. Enumérer les néphropathies glomérulaires pouvant être révélées par une hématurie.
9. Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant de retenir le diagnostic d'une glomérulonéphrite aiguë chez l'enfant
10. Poser l'indication d'une ponction biopsie rénale devant une hématurie.
11. Citer les principales causes d'hématurie d'origine rénale, vésicale et uréthro-prostatique.
12. Planifier la conduite à tenir en urgence devant une hématurie macroscopique grave d'origine urologique.

34. Hémorragies digestives. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Définir les hémorragies digestives hautes et basses.
2. Décrire la vascularisation artérielle de l'estomac et du duodénum.
3. Décrire le système porte en précisant les anastomoses porto-caves et leurs corrélations cliniques.
4. Expliquer la physiopathologie de l'hémorragie digestive en fonction de l'étiologie.
5. Décrire les différentes circonstances de découverte d'une hémorragie digestive.
6. Réunir les éléments de gravité cliniques, paracliniques et évolutifs d'une hémorragie digestive.
7. Etablir le diagnostic étiologique d'une hémorragie digestive à partir des données cliniques et paracliniques.
8. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une hémorragie digestive en fonction de sa gravité et de son étiologie.
9. Expliquer les mesures préventives primaires et secondaires d'une hémorragie digestive.

35. Hépatites virales. Epidémiologie, Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Définir l'hépatite virale.
2. Décrire l'épidémiologie, les modes de transmission et les facteurs de risque des hépatites virales en Tunisie et dans le monde.
3. Décrire les caractéristiques virologiques des différents virus des hépatites.
4. Expliquer les mécanismes immuno-pathologiques des hépatites virales selon le virus en cause.
5. Poser le diagnostic d'une hépatite virale à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
6. Interpréter les différents profils sérologiques des hépatites virales.
7. Indiquer les modalités de surveillance clinique et paraclinique des hépatites virales selon le stade évolutif et le virus en cause.
8. Planifier la stratégie thérapeutique des hépatites virales selon le stade évolutif et le virus en cause.
9. Indiquer les mesures prophylactiques des hépatites virales selon le virus en cause.

36. Hydatidoses hépatiques et pulmonaires thérapeutiques. Epidémiologie, Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite Echinococcus Granulosis et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.
8. Réunir les éléments cliniques et paracliniques du diagnostic positif du kyste hydatique dans sa localisation hépatique et dans ses différentes formes cliniques.
9. Décrire la segmentation tomодensitométrique du foie.
10. Préciser le rôle de la tomодensitométrie dans l'exploration d'une hydatidose hépatique.
11. Identifier les différents types de kystes hydatiques du foie selon la classification échographique de Gharbi.
12. Décrire les principes du traitement chirurgical du kyste hydatique du foie et ses complications.
13. Décrire les moyens de prévention du kyste hydatique.

37. Hypercalcémies. Physiopathologie, Orientation diagnostique, Traitement

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques induisant une hypercalcémie.
2. Décrire les conséquences physiopathologiques de l'hypercalcémie.
3. Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur du diagnostic positif d'une hypercalcémie.
4. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant d'établir le diagnostic étiologique de l'hypercalcémie.
5. Identifier les manifestations cliniques et biologiques d'une « crise aiguë hypercalcémique » en établissant son degré de gravité.
6. Planifier la prise en charge symptomatique et étiologique d'une hypercalcémie.

38. Hypertension artérielle. Epidémiologie, Physiopathologie, Etiopathogénie, Diagnostic, Complications Traitement

1. Expliquer les mécanismes physiologiques de la régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle.
2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'hypertension artérielle.
3. Identifier les facteurs de risque de l'hypertension artérielle de l'adulte.
4. Décrire les facteurs étiopathogéniques de l'hypertension artérielle.
5. Etablir le diagnostic positif de l'hypertension artérielle.
6. Planifier la démarche diagnostique étiologique d'une hypertension artérielle en fonction du contexte clinique.
7. Evaluer le retentissement de l'hypertension artérielle sur les organes cibles.
8. Indiquer le bilan paraclinique nécessaire avant l'instauration du traitement d'une hypertension artérielle.
9. Evaluer le risque cardiovasculaire global d'un patient hypertendu.
10. Planifier la conduite thérapeutique initiale face à une urgence hypertensive.
11. Décrire les mécanismes d'action, les indications et les effets indésirables des différentes classes des médicaments antihypertenseurs.
12. Planifier la conduite thérapeutique chez un patient ayant une hypertension artérielle essentielle.
13. Planifier la surveillance chez un patient avant une hypertension artérielle essentielle.

39. Hyperthyroïdies. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des hyperthyroïdies.
2. Expliquer les conséquences métaboliques et tissulaires des hyperthyroïdies.
3. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de poser le diagnostic d'une hyperthyroïdie.
4. Reconnaître les formes compliquées des hyperthyroïdies en appréciant leur degré de sévérité.
5. Etablir le diagnostic étiologique des hyperthyroïdies.
6. Préciser les particularités cliniques, paracliniques et évolutives des hyperthyroïdies selon leur étiologie et selon le terrain du patient (âge, sexe, grossesse, nouveau-né).
7. Préciser les modalités et les indications thérapeutiques des hyperthyroïdies en fonction de leur sévérité, de leur étiologie et du terrain du patient
8. Planifier la surveillance à court et à long terme de l'hyperthyroïdie en fonction du traitement utilisé.

40. Hyperthyroïdies de l'enfant et de l'adulte. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des hypothyroïdies congénitales et acquises.
2. Expliquer les répercussions physiopathologiques des hypothyroïdies en fonction de l'âge de survenue de la maladie.
3. Réunir les éléments anamnestiques et cliniques permettant de suspecter le diagnostic positif d'une hypothyroïdie en fonction de l'âge (nouveau-né, nourrisson, enfant, adulte).
4. Décrire les moyens d'exploration fonctionnelle hormonale d'une hypothyroïdie : dosages statiques et dynamiques.
5. Décrire les formes compliquées des hypothyroïdies en appréciant leur degré de gravité.
6. Distinguer sur les plans clinique et paraclinique une hypothyroïdie périphérique, d'une hypothyroïdie centrale.
7. Réunir les éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques permettant de rattacher une hypothyroïdie périphérique à son étiologie.
8. Reconnaître les particularités cliniques, paracliniques et évolutives des hypothyroïdies selon le terrain (âge, sexe, grossesse).
9. Rechercher, chez un patient présentant une hypothyroïdie d'origine auto-immune, les affections associées.
10. Préciser les particularités cliniques, paracliniques et évolutives de l'hypothyroïdie fruste (infraclinique).
11. Planifier la stratégie thérapeutique d'une hypothyroïdie en fonction du niveau périphérique ou central de l'atteinte, de sa sévérité, de son étiologie et du terrain du patient
12. Planifier la surveillance au long cours, clinique et paraclinique d'une hypothyroïdie traitée.
14. Procéder à l'éducation thérapeutique d'un patient traité pour hypothyroïdie.
15. Décrire les modalités évolutives de l'hypothyroïdie congénitale en indiquant les éléments du pronostic.

41. Ictères. Physiopathologie, Diagnostic.

1. Définir un ictère.
2. Décrire l'anatomie des voies biliaires intra et extra-hépatiques et du carrefour bilio-pancréatique.
3. Décrire le métabolisme de la bilirubine.
4. Expliquer, en fonction de l'âge, les mécanismes physiopathologiques des ictères à bilirubine conjuguée et des ictères à bilirubine non conjuguée.
5. Distinguer à partir des données de l'anamnèse, de l'examen physique et de la biologie un ictère à bilirubine conjuguée d'un ictère à bilirubine non conjuguée.
6. Planifier, en fonction de l'âge, une démarche diagnostique devant un ictère à bilirubine conjuguée et un ictère à bilirubine non conjuguée.

42. Infections des voies aériennes supérieures. Diagnostic, Traitement.

1. Définir les infections des voies aériennes supérieures (rhinosinusite, angine, laryngite, otite).
2. Enumérer les différents agents infectieux responsables des infections des voies aériennes supérieures, en fonction de l'âge et du terrain.
3. Evoquer le diagnostic d'une infection des voies aériennes supérieures à partir des données anamnestiques et cliniques.
4. Préciser la place des examens complémentaires pour le diagnostic des infections des voies aériennes supérieures.
5. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques, les différentes formes cliniques des infections des voies aériennes supérieures, selon l'âge, le terrain, la localisation et le degré de gravité.
6. Citer les complications évolutives des infections des voies aériennes supérieures.
7. Planifier la prise en charge thérapeutique des différentes formes d'infections des voies aériennes supérieures, selon l'âge, le terrain, la localisation et le degré de gravité.

43. Infections respiratoires basses communautaires. Facteurs de risque, Diagnostic, Traitement.

1. Enumérer les principaux germes responsables des infections respiratoires basses.
2. Poser le diagnostic d'une bronchite aiguë à partir des données cliniques.
3. Prescrire le traitement d'une bronchite aiguë.
4. Décrire les facteurs favorisant la survenue d'une infection respiratoire basse communautaire.
5. Décrire les tableaux radio-cliniques des infections respiratoires basses communautaires.
6. Préciser les différents types de prélèvements microbiologiques à réaliser au cours des infections respiratoires basses communautaires et leurs indications en fonction de la situation clinique.
7. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les différentes formes cliniques des infections respiratoires basses communautaires en fonction du terrain, de l'âge, de la gravité et du germe.
8. Reconnaître à partir des données cliniques et paracliniques les complications évolutives d'une infection respiratoire basse communautaire.
9. Citer les principaux diagnostics différentiels d'une infection respiratoire basse communautaire.
10. Poser l'indication d'hospitalisation d'un patient présentant une infection respiratoire basse communautaire.
11. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une infection respiratoire basse communautaire en fonction du terrain, de l'âge, de la gravité et du germe.

44. Infections sexuellement transmissibles. Etiopathogénie, Diagnostic, Traitement.

1. Enumérer les principales infections sexuellement transmissibles en Tunisie.
2. Citer les principaux agents infectieux responsables des infections sexuellement transmissibles.
3. Décrire l'épidémiologie des infections sexuellement transmissibles en Tunisie.
4. Citer les modes de transmission des principales infections sexuellement transmissibles.
5. Décrire la physiopathologie de l'infection par le VIH.
6. Evoquer l'étiologie d'une infection sexuellement transmissible à partir des données de l'anamnèse et de l'examen physique.
7. Indiquer les examens complémentaires permettant d'évoquer le diagnostic d'une infection sexuellement transmissible.
8. Poser le diagnostic positif d'une infection sexuellement transmissible à partir des données cliniques et paracliniques.
9. Décrire les modes évolutifs et les complications des infections sexuellement transmissibles.
10. Planifier le traitement curatif d'une infection sexuellement transmissible en fonction de l'étiologie.
11. Etablir une stratégie de prévention des infections sexuellement transmissibles.

45. Infections urinaires. Epidémiologie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire les mécanismes physiopathologiques des infections urinaires.
2. Préciser les différents agents infectieux responsables des infections urinaires en fonction de l'âge et du terrain, et leur profil de sensibilité aux antibiotiques.
3. Identifier à partir des données de l'examen clinique et des examens complémentaires, les facteurs favorisant les infections urinaires chez l'enfant et chez l'adulte.
4. Etablir, en fonction de l'âge, le diagnostic positif d'une infection urinaire à partir des données cliniques et paracliniques.
5. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les différentes formes cliniques des infections urinaires.
6. Planifier les examens complémentaires nécessaires à la prise en charge d'une infection urinaire en fonction de la topographie et du terrain.
7. Interpréter les résultats de l'examen cyto bactériologique des urines en fonction des données cliniques.
8. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les complications aiguës et chroniques des infections urinaires.
9. Planifier les explorations radiologiques à visée étiologique au décours d'un épisode d'infection urinaire et en cas de récurrence.
10. Planifier le traitement curatif et préventif chez un patient consultant pour une infection urinaire.
11. Enumérer les arguments cliniques et paracliniques de surveillance des infections urinaires après traitement.
12. Justifier par leurs caractéristiques pharmacocinétiques et / ou pharmacodynamiques l'indication des différents antibiotiques utilisés dans le traitement des infections urinaires.
13. Décrire les effets indésirables des antibiotiques utilisés dans le traitement des infections urinaires.
14. Etablir une démarche de surveillance clinique et paraclinique d'un patient traité pour une infection urinaire.

46. Insuffisance rénale aiguë. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes de la filtration glomérulaire et de sa régulation.
2. Définir la clairance rénale.
3. Indiquer les méthodes de mesure du débit de filtration glomérulaire et du débit sanguin rénal.
4. Définir l'insuffisance rénale aiguë (IRA).
5. Expliquer les principaux mécanismes physiopathologiques impliqués dans l'IRA fonctionnelle, l'IRA obstructive et les IRA parenchymateuses.
6. Différencier une insuffisance rénale aiguë d'une insuffisance rénale chronique sur les données cliniques, biologiques et morphologiques.
7. Reconnaître le caractère fonctionnel, organique ou obstructif d'une IRA à partir des données anamnestiques, cliniques, biologiques (sanguines et urinaires), et échographiques.
8. Déterminer les signes de gravité cliniques, biologiques et morphologiques d'une IRA.
9. Planifier la prise en charge immédiate de la forme grave d'une IRA.
10. Etablir le diagnostic positif d'une IRA obstructive à partir des données anamnestiques, cliniques et échographiques.
11. Indiquer un drainage urgent des voies excrétrices au cours de l'IRA par obstacle.
12. Enumérer les éléments cliniques et biologiques permettant le diagnostic précoce d'un syndrome de levée d'obstacle.
13. Décrire les circonstances de survenue d'une IRA fonctionnelle.
14. Etablir la démarche diagnostique étiologique devant une IRA par nécrose tubulaire aiguë.
15. Poser l'indication d'une ponction biopsie rénale chez un patient présentant une IRA organique.
16. Décrire les différentes formes anatomo-cliniques d'une IRA organique.
17. Décrire les principes de traitement d'une IRA fonctionnelle ou organique selon les mécanismes physiopathologiques incriminés.
18. Planifier la prise en charge thérapeutique et les indications de l'épuration extra-rénale en cas d'IRA.
19. Décrire les modalités évolutives d'une IRA en fonction du type et du terrain.
20. Décrire les principales modalités de prévention des insuffisances rénales aiguës,

47. Insuffisance surrénalienne aiguë. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques aigus et chroniques de l'insuffisance surrénalienne aiguë.
2. Préciser les blocs enzymatiques de la stéroïdogenèse pouvant entraîner une insuffisance surrénalienne.
3. Expliquer les conséquences métaboliques et fonctionnelles d'une insuffisance surrénalienne aiguë.
4. Etablir le diagnostic positif d'une insuffisance surrénalienne aiguë à partir des données cliniques et paracliniques.
5. Réunir les éléments cliniques et paracliniques de gravité d'une insuffisance surrénalienne aiguë.
6. Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur de l'origine centrale ou périphérique d'une insuffisance surrénalienne aiguë en précisant son étiologie.
7. Planifier la prise en charge en urgence d'une insuffisance surrénalienne aiguë.
8. Planifier la démarche d'exploration étiologique chez un patient ayant présenté une insuffisance surrénalienne aiguë.
9. Indiquer les mesures préventives thérapeutiques et éducatives, d'une décompensation aiguë chez un patient insuffisant surrénalien.
10. Indiquer les mesures préventives permettant d'éviter la survenue d'une insuffisance surrénalienne aiguë chez un patient traité par les corticoïdes.

48. Intoxications par le CO, les organophosphorés et les psychotropes. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

Intoxications par le CO.

1. Décrire le rôle de l'hémoglobine dans le transport des gaz respiratoires.
2. Décrire la chaîne de formation du monoxyde de carbone (CO).
3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la toxicité du CO.
4. Décrire les circonstances de survenue d'une intoxication oxycarbonée.
5. Etablir le diagnostic d'une intoxication oxycarbonée, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
6. Planifier la prise en charge thérapeutique de l'intoxication oxycarbonée selon le terrain et la gravité.
7. Préciser les complications et les séquelles de l'intoxication au CO.

Intoxications par les organophosphorés.

8. Expliquer le mécanisme physiopathologique de l'intoxication aux organophosphorés.
9. Décrire les circonstances de survenue d'une intoxication aiguë ou chronique par les organophosphorés.
10. Etablir le diagnostic d'une intoxication aiguë ou chronique par les organophosphorés, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
11. Planifier la prise en charge thérapeutique de l'intoxication aiguë par les organophosphorés.
12. Préciser les paramètres de surveillance cliniques et paracliniques de l'intoxication aiguë par les organophosphorés.
13. Reconnaître les complications immédiates, à moyen et à long terme de l'intoxication aiguë et chronique aux organophosphorés.
14. Etablir les modalités de prévention de l'intoxication aiguë et chronique par les organophosphorés.

Intoxications par les psychotropes.

15. Classer les psychotropes en fonction de leurs propriétés pharmacodynamiques.
16. Etablir le diagnostic d'une intoxication aiguë aux psychotropes, à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
17. Préciser les critères de gravité cliniques et paracliniques de l'intoxication aiguë aux psychotropes.
18. Planifier la conduite thérapeutique symptomatique et spécifique de l'intoxication aiguë aux psychotropes.

49. Ischémie aiguës des membres. Physiopathologie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Décrire la vascularisation artérielle des membres.
2. Expliquer les mécanismes étiopathogéniques aboutissant à une ischémie aiguë des membres (IAM).
3. Expliquer les conséquences physiopathologiques de l'interruption du flux artériel d'un membre.
4. Décrire les mécanismes et les conséquences physiopathologiques du syndrome de revascularisation.
5. Reconnaître les signes cliniques et biologiques de gravité d'une IAM.
6. Etablir le diagnostic d'une IAM à partir des données cliniques et paracliniques.
7. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant de préciser l'étiologie d'une IAM.
8. Evaluer le pronostic d'une IAM sur les données cliniques et paracliniques.
9. Planifier une prise en charge thérapeutique urgente d'une IAM.
10. Préciser les mesures préventives et les principes de l'éducation d'un artéritique.

50. Lithiase urinaire. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes de la lithogénèse en précisant les facteurs de risque d'une lithiase urinaire.
2. Décrire les différents types physico-chimiques de la lithiase urinaire en précisant leurs propriétés.
3. Décrire les formes cliniques de la lithiase urinaire,
4. Poser le diagnostic positif de la lithiase urinaire à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
5. Décrire les mécanismes du retentissement mécanique et infectieux d'une lithiase sur l'appareil urinaire.
6. Evaluer le retentissement organique et fonctionnel des lithiases urinaires à partir des données cliniques et paracliniques.
7. Réunir les arguments biologiques et radiologiques du diagnostic étiologique d'une lithiase urinaire.
8. Décrire les moyens thérapeutiques médicaux et chirurgicaux de la lithiase urinaire et leurs indications.
9. Enumérer les éléments de suivi d'un patient présentant une lithiase urinaire.
10. Expliquer les mesures à prescrire pour prévenir les récides de la lithiase.

51. Maladies veineuses thrombo-emboliques. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire l'étiopathogénie et les conséquences physiopathologiques de la maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE).
2. Citer les facteurs de risque de la MVTE.
3. Evoquer à partir des données de l'anamnèse et de l'examen physique le diagnostic de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire.
4. Hiérarchiser la prescription des examens paracliniques d'une MVTE en fonction du terrain et des signes de gravité en vue de confirmer le diagnostic.
5. Etablir le diagnostic étiologique de la MVTE à partir des données de l'anamnèse, de l'examen physique et des examens paracliniques.
6. Décrire les formes cliniques (symptomatiques, topographiques et selon le terrain) de la MVTE.
7. Décrire les complications de la MVTE à court, à moyen et à long terme.
8. Citer les diagnostics différentiels d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs.
9. Planifier le traitement curatif, préventif et la surveillance de la MVTE.
10. Décrire les principales interactions médicamenteuses des anticoagulants.

52. Méningites bactériennes et virales. Etiopathogénie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire les mécanismes physiopathologiques d'une méningite aiguë.
2. Décrire les principaux agents infectieux responsables des méningites aiguës en fonction de l'âge et du terrain.
3. Reconnaître à partir des données anamnestiques et cliniques les signes évocateurs d'une méningite en fonction de l'âge.
4. Identifier les contre-indications et les précautions à prendre avant la réalisation d'une ponction lombaire devant un patient présentant un syndrome méningé fébrile.
5. Interpréter les données de la ponction lombaire en cas de méningite aiguë.
6. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les critères de gravité d'une méningite.
7. Etablir le diagnostic étiologique d'une méningite aiguë à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques en fonction de l'âge.
8. Planifier le traitement curatif et préventif devant une méningite aiguë en fonction de l'âge.
9. Etablir les éléments de surveillance clinique et paracliniques d'une méningite aiguë.
10. Décrire les modalités évolutives de la méningite aiguë.

53. Métrorragies, Orientation Diagnostique.

1. Définir les métrorragies.
2. Identifier les éléments de gravité d'une métrorragie.
3. Indiquer les premiers gestes d'urgence devant une métrorragie grave.
4. Expliquer les mécanismes des métrorragies fonctionnelles.
5. Etablir à partir des données cliniques et paracliniques, les diagnostics étiologiques des métrorragies selon le terrain en dehors de la grossesse.
6. Etablir la démarche du diagnostic étiologique des métrorragies au cours de la grossesse, du travail et du post-partum.

54. Occlusions Intestinales aiguës. Physiopathologie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Définir une occlusion intestinale aiguë.
2. Expliquer les mécanismes étiopathogéniques et les conséquences anatomo-pathologiques des occlusions intestinales aiguës.
3. Expliquer les conséquences physiopathologiques d'une occlusion intestinale aiguë.
4. Etablir le diagnostic positif d'une occlusion intestinale aiguë à partir des données de l'examen clinique et de la radiographie de l'abdomen sans préparation.
5. Reconnaître à partir des données de l'examen clinique, des examens paracliniques et du terrain, les signes de gravité d'une occlusion intestinale aiguë.
6. Réunir les éléments cliniques et paracliniques permettant d'identifier le niveau, le mécanisme et l'étiologie de l'occlusion intestinale aiguë.
7. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une occlusion intestinale aiguë en fonction de sa gravité, de son mécanisme de son niveau, de sa cause et du terrain du patient.

55. Œdèmes. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic.

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des œdèmes généralisés et localisés.
2. Distinguer les différents types d'œdèmes à partir de leurs caractéristiques cliniques.
3. Etablir le diagnostic étiologique des différents types d'œdème à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
4. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les signes de gravité associés aux œdèmes.
5. Poser l'indication d'une hospitalisation d'un patient qui consulte pour œdèmes.

56. Œil rouge. Orientation Diagnostique.

1. Etablir le diagnostic de gravité d'une rougeur oculaire à partir des données relatives au contexte, au siège de la rougeur et aux symptômes associés.
2. Réunir les éléments cliniques qui orientent vers une crise aiguë de glaucome primitif par fermeture de l'angle.
3. Expliquer la physiopathologie de la crise aiguë de glaucome primitif par fermeture de l'angle en se basant sur l'anatomie de l'angle irido-cornéen.
4. Enumérer les autres étiologies d'un œil rouge douloureux.

57. Péritonites aiguës. Physiopathologie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Définir les péritonites aiguës (PA).
2. Expliquer les mécanismes étiopathogéniques des PA.
3. Expliquer les conséquences physiopathologiques d'une PA.
4. Décrire les aspects anatomo-pathologiques des PA.
5. Identifier les éléments cliniques permettant de poser le diagnostic de PA.
6. Apprécier sur les données cliniques et paracliniques la gravité d'une PA.
7. Etablir le diagnostic étiologique d'une PA à partir des données cliniques et paracliniques.
8. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une PA dans ses différentes formes cliniques.

58. Polyarthrite rhumatoïde. Etiopathogénie. Diagnostic.

1. Définir la polyarthrite rhumatoïde.
2. Préciser l'épidémiologie de la polyarthrite rhumatoïde.
3. Expliquer les mécanismes étiopathogéniques de la polyarthrite rhumatoïde.
4. Expliquer les mécanismes immunopathologiques impliqués dans la destruction articulaire.
5. Réunir les arguments cliniques et paracliniques permettant d'évoquer le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde en phase de début.
6. Décrire les différentes manifestations articulaires et extra-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde à la phase d'état.
7. Interpréter les examens immunologiques de la polyarthrite rhumatoïde.
8. Préciser les facteurs prédictifs de sévérité d'une polyarthrite rhumatoïde débutante.
9. Enumérer les critères diagnostiques et de classification de la polyarthrite rhumatoïde.
10. Réunir les arguments cliniques et paracliniques permettant de distinguer la polyarthrite rhumatoïde débutante des autres causes d'atteinte articulaire.

59. Polytraumatisme. Physiopathologie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Définir la notion du polytraumatisme.
2. Etablir le bilan lésionnel chez un polytraumatisé sur les bases de l'anatomie topographique et des circonstances de l'accident.
3. Expliquer les mécanismes des détresses vitales chez un polytraumatisé.
4. Expliquer l'importance des associations lésionnelles dans les modifications physiopathologiques observées chez un polytraumatisé.
5. Décrire la prise en charge pré-hospitalière d'un polytraumatisé.
6. Planifier la stratégie de prise en charge diagnostique et thérapeutique hospitalière initiale d'un polytraumatisé.
7. Etablir, à partir des données de l'examen clinique et paracliniques, les éléments de gravité chez un polytraumatisé.
8. Enumérer les objectifs de la rééducation fonctionnelle d'un polytraumatisé au décours de la phase aiguë

60. Prééclampsies et Eclampsies. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la prééclampsie.
2. Préciser les facteurs de risque de la prééclampsie.
3. Etablir le diagnostic positif d'une prééclampsie et d'une éclampsie à partir des données cliniques et paracliniques.
4. Reconnaître les éléments de gravité de la prééclampsie.
5. Réunir les éléments cliniques et paracliniques du retentissement maternel et fœtal de la prééclampsie et de l'éclampsie.
6. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une femme présentant une prééclampsie.
7. Décrire la prise en charge médicale et obstétricale en urgence de la crise d'éclampsie.
8. Planifier les modalités de dépistage et de prévention de la prééclampsie.
9. Planifier la surveillance maternelle et fœtale devant un état de prééclampsie au cours de la grossesse, au cours du travail et dans le post-partum.

61. Prise en charge de la douleur aiguë, Evaluation, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes de contrôle médullaire et supra-médullaire de la douleur.
2. Décrire les différents types de douleur aiguë en fonction de leurs étiologies.
3. Décrire les différents facteurs intervenant dans l'expression de la douleur.
4. Décrire les modalités d'utilisation des différentes échelles d'évaluation de l'intensité de la douleur.
5. Définir une douleur aiguë sévère.
6. Planifier une prise en charge thérapeutique de la douleur en fonction de sa sévérité et de son étiologie.
7. Décrire la classification des médicaments antalgiques selon les critères de l'OMS.
8. Expliquer le mécanisme d'action antalgique, les effets pharmacodynamiques et les effets indésirables de chaque classe médicamenteuse utilisée dans le traitement de la douleur.
9. Décrire les règles de prescription des médicaments antalgiques.

62. Purpuras. Etiopathogénie, Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Etablir le diagnostic positif d'un purpura à partir des données de l'examen physique.
2. Expliquer les différents mécanismes physiopathologiques à l'origine d'un purpura.
3. Identifier les éléments de gravité d'un purpura à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
4. Etablir le diagnostic étiologique d'un purpura à partir des éléments anamnestiques, cliniques, paracliniques et en fonction de l'âge.
5. Planifier la prise en charge thérapeutique et la surveillance d'un patient présentant un purpura en fonction de son étiologie.

63. Schizophrénie. Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Définir la schizophrénie.
2. Etablir le diagnostic positif de la schizophrénie, à partir des données anamnestiques et cliniques.
3. Identifier les diagnostics différentiels de la schizophrénie à partir des données anamnestiques et cliniques.
4. Décrire les modalités évolutives de la schizophrénie.
5. Planifier la prise en charge médicamenteuse, psychologique et sociale de la schizophrénie.
6. Préciser les éléments de surveillance d'un antipsychotique au long cours.

64. Splénomégalias. Physiopathologie, Diagnostic.

1. Etablir le diagnostic positif d'une splénomégalie à partir des données cliniques et radiologiques.
2. Expliquer les mécanismes physiopathologiques à l'origine d'une splénomégalie.
3. Décrire les circonstances de découverte d'une splénomégalie.
4. Différencier par l'examen clinique et l'imagerie médicale une splénomégalie d'une autre masse de l'hypochondre gauche.
5. Réunir les arguments anamnestiques et cliniques permettant l'orientation du diagnostic étiologique en fonction de l'âge.
6. Planifier les examens complémentaires à réaliser chez un patient présentant une splénomégalie, en fonction de l'orientation étiologique.

65. Syndromes coronariens aigus. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire l'anatomie de la vascularisation artérielle cardiaque.
2. Expliquer les mécanismes et les conséquences physiopathologiques des syndromes coronariens aigus.
3. Etablir le diagnostic positif d'un syndrome coronarien aigu à partir des données de l'anamnèse, de l'électrocardiogramme et de la biologie.
4. Stratifier le risque cardiovasculaire d'un patient ayant un syndrome coronarien aigu.
5. Etablir les diagnostics différentiels d'un syndrome coronarien aigu.
6. Enumérer les différents facteurs de risque cardiovasculaire des syndromes coronariens aigus.
7. Décrire les modalités évolutives et les complications précoces et tardives d'un syndrome coronarien aigu.
8. Planifier la prise en charge thérapeutique initiale des syndromes coronariens aigus STC (+).
9. Planifier la stratégie thérapeutique d'un syndrome coronarien aigu STC (-) en précisant les indications du traitement pharmacologique et la place de la coronarographie, en fonction de la gravité.
10. Décrire le mécanisme d'action, les indications, les contre-indications, les modalités d'administration et les effets indésirables des fibrinolytiques.
11. Décrire le mécanisme d'action et les principaux effets indésirables des différentes classes médicamenteuses utilisées dans le traitement des syndromes coronariens aigus.
12. Indiquer les éléments de surveillance cliniques et paracliniques des syndromes coronariens aigus.
13. Planifier la stratégie d'exploration clinique et paraclinique après chez un patient ayant présenté un syndrome coronarien aigu.
14. Rédiger l'ordonnance de sortie chez un patient ayant présenté un syndrome coronarien aigu.

66. Transfusion sanguine. Bases immuno-hématologiques, Indications, Complications.

1. Expliquer les caractéristiques biochimiques, génétiques, immunologiques de répartition cellulaire des systèmes ABO et Rhésus (y compris le D faible et partiel).
2. Expliquer les circonstances d'apparition et les conséquences immuno-hématologiques d'une hémolysine anti-A et/ou anti-B.
3. Expliquer l'intérêt immuno-hématologique des sous-groupes A1 et A2.
4. Décrire les caractéristiques immunologiques et l'intérêt immuno-hématologique des systèmes apparentés aux systèmes ABO et Rhésus.
5. Justifier selon l'indication clinique le choix des produits sanguins stables et labiles.
6. Expliquer les principes et les indications des tests de Coombs direct et indirect.
7. Préciser les règles transfusionnelles et les tests immuno-hématologiques à respecter de façon absolue en fonction du produit sanguin labile transfusé.
8. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des différents accidents transfusionnels.
9. Planifier la prise en charge d'un accident transfusionnel.
10. Etablir les mesures préventives des complications transfusionnelles.

67. Traumatisme crânien. Physiopathologie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques.

1. Décrire l'anatomie topographique de la boîte crânienne. .
2. Expliquer la régulation de la pression intra crânienne et de la pression de perfusion cérébrale.
3. Définir le niveau de gravité du traumatisme crânien en se référant au score du Glasgow.
4. Expliquer les mécanismes lésionnels d'un traumatisme crânien et leurs conséquences physiopathologiques locales et systémiques.
5. Evaluer à partir des données cliniques et paracliniques le degré de gravité immédiate d'un traumatisme crânien.
6. Indiquer les explorations radiologiques nécessaires permettant d'établir le bilan lésionnel d'un traumatisme crânien.
7. Identifier les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS) chez un patient présentant un traumatisme crânien.
8. Planifier la prise en charge thérapeutique pré-hospitalière et hospitalière d'un patient ayant un traumatisme crânien.
9. Préciser les éléments de surveillance cliniques et paracliniques à court et à moyen terme d'un traumatisme crânien.
10. Préciser les objectifs de rééducation fonctionnelle chez le traumatisé crânien à la phase séquellaire.

68. Troubles acido-basiques. Physiopathologie, Diagnostic.

1. Définir le pH sanguin.
2. Décrire le bilan des ions hydrogène dans l'organisme.
3. Décrire le rôle des systèmes tampons dans l'équilibre acido-basique.
4. Expliquer le rôle du poumon et des reins dans l'équilibre acido-basique.
5. Etablir le diagnostic positif d'un trouble acido-basique à partir des données cliniques et paracliniques.
6. Identifier les signes de gravité d'un trouble acido-basique à partir des données cliniques et paracliniques.
7. Etablir le diagnostic étiologique d'un trouble acido-basique à partir des données cliniques et paracliniques.

69. Troubles anxieux. Diagnostic, Traitement.

1. Distinguer l'anxiété normale de l'anxiété pathologique sur des arguments anamnestiques et cliniques.
2. Etablir le diagnostic positif d'un trouble panique et d'un trouble anxiété généralisée, à partir des données de l'anamnèse et de l'examen psychiatrique.
3. Etablir le diagnostic positif d'une agoraphobie, d'une phobie spécifique et d'une phobie sociale, à partir des données de l'anamnèse et de l'examen psychiatrique.
4. Etablir le diagnostic positif d'un trouble anxiété de séparation de l'enfant, à partir des données anamnestiques et cliniques.
5. Différencier les troubles anxieux du trouble obsessionnel compulsif et de l'état de stress post-traumatique, à partir des données anamnestiques et cliniques.
6. Etablir les diagnostics différentiels des troubles anxieux.
7. Planifier la conduite du traitement symptomatique et du traitement de fond des différents troubles anxieux.
8. Décrire les propriétés pharmacodynamiques des anxiolytiques.
9. Décrire les règles de prescription des anxiolytiques.
10. Citer les méthodes psychothérapeutiques qui s'appliquent à la prise en charge des différents troubles anxieux.

70. Troubles de l'humeur. Diagnostic traitement.

1. Etablir le diagnostic positif d'un épisode dépressif majeur à partir des données de l'examen clinique.
2. Décrire les différentes formes cliniques de dépression selon l'âge et le terrain.
3. Identifier les facteurs prédisposant à la bipolarité chez un patient déprimé, à partir des données de l'examen clinique.
4. Décrire les modalités évolutives et les complications d'un épisode dépressif.
5. Evaluer le risque suicidaire chez l'adolescent et l'adulte dépressifs à partir des données de l'examen clinique.
6. Etablir les diagnostics différentiels de la dépression.
7. Etablir le diagnostic positif d'un épisode maniaque à partir des données de l'examen clinique.
8. Décrire les différentes formes cliniques de l'accès maniaque.
9. Etablir le diagnostic positif d'un trouble bipolaire I et II à partir des données de l'examen clinique.
10. Décrire les modalités évolutives et les complications des troubles bipolaires de l'humeur.
11. Préciser les diagnostics différentiels des troubles bipolaires de l'humeur.
12. Planifier la conduite du traitement curatif et préventif des troubles dépressifs majeurs récurrents.
13. Planifier la conduite du traitement curatif et préventif des troubles bipolaires de l'humeur.
14. Indiquer les éléments de surveillance des antidépresseurs et des thymorégulateurs.

71. Troubles de l'hydratation, dyskaliémies. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire les caractéristiques physico-chimiques des différents compartiments liquidiens de l'organisme.
2. Expliquer le rôle du rein dans la balance hydro-électrolytique.
3. Décrire la régulation hormonale et comportementale (soif) de l'équilibre hydro-électrolytique.
4. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des différents troubles de l'hydratation.
5. Etablir le diagnostic positif d'un trouble de l'hydratation à partir des données cliniques et paracliniques.
6. Déterminer les signes de gravité d'un trouble de l'hydratation.
7. Etablir le diagnostic étiologique d'un trouble de l'hydratation à partir des données cliniques et paracliniques.
8. Planifier la prise en charge thérapeutique selon le type de trouble de l'hydratation.
9. Décrire les éléments cliniques et paracliniques de surveillance d'un patient ayant un trouble de l'hydratation.
10. Planifier la prévention d'un trouble de l'hydratation en fonction du terrain.
11. Définir une hyperkaliémie et une hypokaliémie.
12. Décrire les mécanismes de régulation de la kaliémie.
13. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des dyskaliémies.
14. Identifier les signes d'une dyskaliémie à partir des données cliniques et paracliniques.
15. Evaluer la gravité d'une dyskaliémie à partir des données cliniques et paracliniques.
16. Etablir le diagnostic étiologique d'une dyskaliémie à partir des données cliniques et paracliniques.

72. Tuberculose pulmonaire commune. Epidémiologie, Etiopathogénie, Diagnostic, Traitement.

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose pulmonaire dans le monde et en Tunisie.
2. Décrire les caractéristiques bactériologiques du mycobacterium tuberculosis.
3. Décrire la pathogénie et la physiopathologie de l'infection tuberculeuse.
4. Décrire les lésions anatomopathologiques élémentaires de la tuberculose pulmonaire.
5. Énumérer les facteurs de risque de la tuberculose pulmonaire.
6. Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et radiologiques permettant de suspecter une tuberculose pulmonaire évolutive.
7. Décrire les techniques de prélèvement bactériologique permettant le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire.
8. Réunir les arguments bactériologiques nécessaires au diagnostic d'une tuberculose pulmonaire.
9. Décrire les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire.
10. Etablir les diagnostics différentiels de la tuberculose pulmonaire.
11. Planifier la prise en charge thérapeutique de la tuberculose pulmonaire commune pour un nouveau cas, selon le programme national de lutte anti-tuberculeuse (PNLT) en précisant les modalités d'indication, de prescription, de surveillance et d'observance.
12. Décrire les critères de guérison et d'échec thérapeutique de la tuberculose pulmonaire.
13. Indiquer les mesures médico-sociales et légales chez un patient présentant une tuberculose pulmonaire.
14. Préciser les mesures préventives et les indications de la chimioprophylaxie en cas de tuberculose pulmonaire.

73. Tumeurs de la prostate. Etiopathogénie, Diagnostic, Orientations thérapeutiques,

1. Décrire l'anatomie de la loge prostatique (anatomie zonale, drainage lymphatique et rapports).
2. Décrire les particularités épidémiologiques de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du cancer de la prostate.
3. Décrire les aspects anatomopathologiques des tumeurs bénignes et malignes de la prostate.
4. Expliquer les conséquences physiopathologiques secondaires à l'existence d'une hypertrophie bénigne de la prostate.
5. Réunir les éléments cliniques et paracliniques, permettant le diagnostic d'une hypertrophie bénigne de la prostate.
6. Reconnaître les complications d'une hypertrophie bénigne de la prostate.
7. Décrire les différentes modalités thérapeutiques d'une hypertrophie bénigne de la prostate ainsi que leurs indications et leurs complications.
8. Réunir les éléments cliniques et paracliniques en faveur du diagnostic du cancer de la prostate.
9. Etablir le bilan d'extension du cancer de la prostate à partir des données cliniques et paracliniques.
10. Planifier la prise en charge thérapeutique du cancer prostatique en fonction des stades évolutifs.
11. Expliquer les bases de la surveillance post-thérapeutique d'un cancer prostatique.
12. Evaluer le pronostic d'un cancer de la prostate à partir des données cliniques et paracliniques.

74. Ulcère gastrique et duodéal. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement.

1. Expliquer les mécanismes de la sécrétion acide gastrique et sa régulation.
2. Décrire les lésions anatomopathologiques de l'ulcère gastrique et duodéal et les lésions associées.
3. Décrire les facteurs étiopathogéniques de la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale.
4. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale.
5. Poser le diagnostic de la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale à partir des données cliniques et paracliniques.
6. Reconnaître les formes compliquées de la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale à partir des données cliniques et paracliniques.
7. Planifier la prise en charge thérapeutique de la maladie ulcéreuse gastrique et duodénale, dans ses différentes formes.

75. Vaccinations. Bases scientifiques et indications.

1. Décrire les bases immunologiques de la réponse post vaccinale induite.
2. Décrire les différents types de vaccins.
3. Décrire la qualité requise d'un bon vaccin.
4. Citer les effets indésirables des vaccins obligatoires en Tunisie.
5. Enumérer les contre-indications des vaccins obligatoires en Tunisie.
6. Décrire le calendrier vaccinal tunisien en vigueur.
7. Indiquer les vaccins recommandés en fonction de circonstances particulières et en cas de voyage.

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination de chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé publique du 21 octobre 1982, portant organisation du concours de résidanat en médecine dentaire, modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Arrêtent :

Article premier - Un concours de résidanat en médecine dentaire est ouvert à Monastir, le 17 novembre 2015 et jours suivants, pour le recrutement de (40) résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de médecine dentaire de Monastir, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 21 octobre 1982, modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Art. 2 - Pour les candidats médecins dentistes de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins et dans le cadre de la formation continue, ce concours est ouvert dans la limite de 10% pour le nombre de postes ci-dessus indiqués et dans les spécialités suivantes :

- médecine et chirurgie buccales : 2 postes,
- parodontologie : 1 poste,
- odontologie pédiatrique et prévention : 1 poste.

Art. 3 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 23 octobre 2015.

Tunis, le 4 septembre 2015.

Le ministre de la santé

Saïd Aïdi

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Chiheb Bouden

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant ouverture d'un concours pour le recrutement des résidents en pharmacie.

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 décembre 2010, portant organisation du concours de résidanat en pharmacie.

Arrêtent :

Article premier - Un concours de résidanat en pharmacie est ouvert à Monastir, le 24 novembre 2015 et jours suivants, pour le recrutement de 60 résidents en pharmacie, pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de pharmacie de Monastir, conformément aux dispositions de l'arrêté d'organisation du concours précité.

Art. 2 - Pour les candidats cités au 1^{er} paragraphe, 2^{ème} paragraphe et 3^{ème} paragraphe de l'article 2 (nouveau) du décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010, ce concours est ouvert dans les spécialités et les options et pour le nombre des postes ci-dessous :

1- Biologie	Nombre des postes ouverts
Biologie médicale humaine : option biochimie	7
Biologie médicale humaine : option hématologie	7
Biologie médicale humaine : option toxicologie	3
Biologie médicale humaine : option microbiologie	7
Biologie médicale humaine : option immunologie	4
Biologie médicale humaine : option parasitologie	4
Biologie médicale humaine : option virologie	2
Biologie médicale humaine : option génétique et biologie de la reproduction	2

2-Pharmacie hospitalière et industrielle	Nombre des postes ouverts
Pharmacie hospitalière et industrielle : option pharmacie galénique	3
Pharmacie hospitalière et industrielle : option biophysique	1
Pharmacie hospitalière et industrielle : option chimie organique	1
Pharmacie hospitalière et industrielle : option chimie thérapeutique	2
Pharmacie hospitalière et industrielle : option chimie analytique	3
Pharmacie hospitalière et industrielle : option pharmacologie	4
Pharmacie hospitalière et industrielle : option pharmacie clinique	2
Pharmacie hospitalière et industrielle : option physiologie humaine et explorations fonctionnelles	1
Pharmacie hospitalière et industrielle : option pharmacognosie	1

Art. 3. - Pour les candidats cités au 4^{ème} paragraphe de l'article 2 (nouveau) du décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010, ce concours est ouvert dans les spécialités et les options et pour le nombre des postes ci-dessous :

1- Biologie	Nombre des postes ouverts
Biologie médicale humaine : option microbiologie	1
Biologie médicale humaine : option hématologie	1
Biologie médicale humaine : option parasitologie	1
Biologie médicale humaine : option biochimie	1
2-Pharmacie Hospitalière et Industrielle	Nombre des postes ouverts
Pharmacie hospitalière et industrielle : option pharmacie clinique	2

Art. 4 - La clôture du registre des candidatures est fixée au 23 octobre 2015.

Tunis, le 4 septembre 2015.

Le ministre de la santé

Saïd Aïdi

*Le ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique*

Chiheb Bouden

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Par décret gouvernemental n° 2015-1196 du 4 septembre 2015.

Monsieur Fayçal Sahraoui, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef d'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2014-3674 du 3 octobre 2014, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Décret gouvernemental n° 2015-1197 du 27 août 2015, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-118 du 9 janvier 1989, relatif à la création du conseil islamique supérieur, tel qu'il est modifié et complété par le décret n° 93-1449 du 5 juillet 1993,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il est modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel qu'il est modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret n° 2008-3123 du 23 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD",

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,

Vu le décret n° 2010-471 du 15 mars 2010, fixant les indemnités attribuées aux enseignants chargés d'emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2014-3474 du 23 septembre 2014, portant création de l'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nominations du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'organisation administrative et financière de l'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan est fixée selon les dispositions générales appliquées aux établissements de l'enseignement supérieur et de recherche et selon les dispositions du présent décret gouvernemental.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 2 - L'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche en cotutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère des affaires religieuses. Le dit institut est rattaché à l'université Ezzitouna et assure la formation fondamentale dans la prédication et l'initiation religieuse.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 3 - L'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan comprend :

- le directeur,
- le secrétariat général,
- le conseil scientifique,
- le comité pour la qualité,
- les départements,
- le conseil de discipline.

Section I - Le directeur

Art. 4- L'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan est dirigé par un directeur est nommé par décret gouvernemental après élection par les personnels de l'enseignement et du recherche membres au conseil scientifique. Le directeur est élu parmi le personnel d'enseignement et de recherche membres élus du conseil scientifique ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou maître de conférences. La candidature des maîtres assistants titulaires peut être acceptée en cas d'absence de candidature d'un professeur d'enseignement supérieur ou d'un maître de conférences. Les chefs des départements nouvellement élus ne peuvent pas se porter candidats aux fonctions de doyen ou directeur. Le doyen ou le directeur est élu par les représentants de personnel de l'enseignement supérieur et de recherche membres au conseil scientifique. Les élections se déroulent au cours d'une séance tenue à cet effet, sur convocation du président de l'université. Est déclaré élu, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité des voix, l'élection est acquise au candidat ayant le grade supérieur, à égalité de grade, au plus ancien dans le grade et à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.

En outre, à défaut de candidature ou empêchement de déroulement des élections pour une raison quelconque, le directeur de l'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan est nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre des affaires religieuses et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur est nommé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 5 - Sous réserve des articles 4 (nouveau) et 28 (nouveau) du décret n° 2008-2716 susvisé, le directeur de l'institut supérieur de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan peut être nommé en dehors du corps des enseignants chercheurs des universités sur proposition du ministre des affaires religieuses et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 6 - Le directeur assure le fonctionnement de l'institut dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives de l'autorité de tutelle, à cet effet, il exerce les attributions suivantes :

- superviser le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l'institut, assurer la coordination des activités d'enseignement dans l'institut et veiller à l'organisation des examens et la désignation des chefs des jurys des examens,
- veiller au maintien de l'ordre et de la discipline au sein de l'institut,

- présider le conseil scientifique mentionné par l'article 3 du présent décret gouvernemental, il arrête son ordre du jour, invite les membres à ses réunions et soumet ses délibérations à l'autorité de tutelle,

- présider le conseil de discipline,

- soumettre au président de l'université un rapport général sur l'activité de l'institut à la fin de chaque année universitaire ainsi que tout autre rapport dont l'autorité de tutelle lui demande,

- veiller au bon fonctionnement des services administratifs et financiers, il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut,

- préparer le projet du budget de l'institut, le soumettre au conseil scientifique pour avis et le transmettre au président de l'université,

- représenter l'institut à l'égard des tiers et à l'égard de la justice dans tous les actes civils, administratifs et juridiques,

- conclure les accords et les contrats après accord du président de l'université,

- signer les diplômes scientifiques délivrés par l'institut,

- préparer le projet de l'établissement qui représente le mode d'exécution de la contractualisation conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008 susvisé, et ce, après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Art. 7 - Pour accomplir ses missions le directeur est assisté par :

- le secrétariat général,

- le conseil scientifique qui a un rôle consultatif,

- le directeur des études et des stages.

Section II - Le secrétariat général

Art. 8 - Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur, assisté par un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Ils sont nommés par décret gouvernemental sur proposition du ministre des affaires religieuses et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret n° 91-517 du 10 avril 1991 susvisé, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal, et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 9 - Le secrétaire général est chargé notamment de :

- assurer la bonne poursuite des études, le respect de l'ordre et de l'hygiène au sein de l'institut,

- assurer la gestion administrative et financière de l'institut et contribue à l'élaboration du budget,

- assurer le secrétariat du conseil scientifique et élaborer les procès-verbaux de ses réunions et transmettre des copies au président de l'université et les membres du conseil dans un délai d'une semaine de la date de la réunion,

- superviser le bureau de vote et le dépouillement des voix relatives à toutes les élections prévues par le présent décret gouvernemental,

- assurer la conservation et l'entretien des matériaux et des équipements.

Section III - Le conseil scientifique

Art.10 - Le conseil scientifique comporte :

- le directeur de l'institut: président du conseil,

- le directeur adjoint,

- les chefs des départements,

- huit (8) membres au moins représentant le personnel de l'enseignement et de recherche élus par leurs pairs à égalité entre les professeurs d'enseignement supérieur et les maîtres de conférence ou les membres du corps enseignant et de recherche ayant un grade équivalent d'une part et les maîtres assistants et les assistants titulaires ou les membres du corps enseignant et de recherche ayant un grade équivalent d'autre part,

- un représentant du corps des professeurs de l'enseignement secondaire et des professeurs du corps commun nommé par le directeur en tant qu'observateur dans le cas où le nombre des enseignants de cette catégorie dépasse un seuil préalablement établi par le conseil de l'université,

- trois étudiants élus chaque année,

- des représentants des instances économiques, sociales et culturelles dont le nombre égale à la moitié du nombre des représentants du personnel de l'enseignement et de recherche et qui sont proposés par les instances auxquels ils appartiennent,

- le secrétaire général : rapporteur,

- si le nombre des professeurs de l'enseignement supérieure et les maîtres de conférences dans l'institut dépasse cinquante (50) enseignants, le conseil scientifique peut comprendre dix (10) membres du corps du personnel de l'enseignement et de recherche élus et répartis comme suit :

* cinq (5) professeurs de l'enseignement supérieur et maîtres de conférences,

* cinq (5) maîtres assistants et assistants titulaires.

Les représentants du personnel de l'enseignement et de recherche membres du conseil scientifique sont élus pour une période de trois ans.

Les enseignants n'appartenant pas au corps du personnel de l'enseignement et de recherche des universités peuvent être élu au conseil scientifique sous réserve des dispositions de l'article 33 (nouveau) du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008 susvisé.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires religieuses.

Le calendrier des élections du conseil scientifique est fixé par le président de l'université.

Art. 11 - Le directeur de l'institut consulte le conseil scientifique à propos de l'organisation des activités de formation et de recherche et ce dans le cadre des lois et réglementations en vigueur et à propos de la gestion de l'institut.

A cet effet, le conseil scientifique est chargé notamment de :

- étudier les questions relatives à l'organisation de l'enseignement, des stages et des activités de recherche au sein de l'institut,

- étudier les projets des conventions et des contrats et ce avant la signature du directeur conformément à la législation en vigueur,

- élaborer du règlement interne de l'institut qui sera approuvé par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

- préparer le projet de l'établissement et assurer son suivi et proposer la création des nouveaux départements et émettre son avis sur le projet du budget de l'établissement après avoir été informé de l'exécution du budget de l'année écoulée.

Il examine également toute autre question relative à l'enseignement ou à la recherche soumise par le directeur de l'institut ou le président de l'université.

Art. 12 - Le conseil scientifique se réunit une fois par mois et chaque fois que son président le juge nécessaire sur convocation de son président ou sur demande de la majorité de ses membres représentant du personnel de l'enseignement et de recherche.

Les réunions du conseil ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins, à défaut du quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours de la semaine suivante, quelque soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le président de l'institut peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugé utile aux travaux du conseil.

Section IV - **Le directeur des études et des stages**

Art. 13 - Le directeur doit obligatoirement présenter deux propositions pour la nomination à la fonction du directeur des études et des stages, dans un délai d'un mois de la date de sa désignation.

En vertu de cette qualité, le directeur des études et des stages est considéré un directeur adjoint.

Le directeur des études et des stages est nommé par un décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires religieuses pour une période de trois ans, parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les maîtres de conférences ou les maîtres assistants de l'enseignement supérieur titulaires.

Les fonctions de directeur des études et des stages prennent fin avec la fin des fonctions du directeur.

Section V - **Le comité pour la qualité**

Art. 14 - Il est créé au sien de l'institut de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan un comité pour la qualité.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité est fixée par décision du président de l'université après avis du conseil scientifique de l'institut.

Section VI - **Les départements**

Art. 15 - Le département comprend tous les membres du personnel de l'enseignement et de recherche de l'institut exerçant dans une discipline ou un groupe de disciplines apparentées.

La liste des départements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires religieuses sur proposition du président de l'université, après avis du directeur de l'institut.

Art. 16 - Le département propose les programmes de formation et veille sur leur exécution et sur l'harmonisation des méthodes pédagogiques ainsi que leur amélioration, il propose également les programmes de recherche, en suit l'exécution et coordonne les recherches effectuées, veille à la meilleure utilisation des moyens et des équipements mis à sa disposition, propose l'organisation des séminaires et des colloques dans son domaine.

Le département est dirigé par un chef de département élu parmi les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les maîtres assistants titulaires appartenant au même département, il peut être élu parmi le personnel de l'enseignement et de recherche ayant des grades équivalents, pour une période de trois années renouvelables une seule fois conformément aux textes juridiques et la réglementation en vigueur.

Les élections des chefs des départements se déroulent durant la première quinzaine du mois de juin.

Le chef de département est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires religieuses.

Les règlements internes de l'université fixent le mode de gestion du département.

Section VII - Le conseil de discipline

Art. 17 - Les étudiants de l'institut doivent respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur et le règlement interne de l'institut de prédication et d'initiation religieuse de Kairouan durant toute la période d'étude.

Art. 18 - Le conseil de discipline examine tout manquement aux obligations universitaires au sein de l'institut et devant les stages émanant des étudiants de l'institut ou toute autre personne prévues à l'article 55 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008 susvisé.

Le conseil de la discipline comprend :

- le président : le directeur de l'institut ou son représentant.
- les membres :
 - un représentant du président de l'université,
 - deux représentants des enseignants membres du conseil scientifique élus par leurs pairs,
 - un étudiant membre du conseil scientifique élu par ses collègues membres dudit conseil,
 - le secrétaire général, rapporteur du conseil.

Art. 19 - Le conseil de discipline se réunit sur convocation du président et ses réunions ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins, à défaut du quorum une deuxième réunion est tenue au cours des cinq jours suivants quelque soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations des réunions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil et une copie est transmise au président de l'université.

Art. 20 - L'étudiant est convoqué au conseil de discipline par l'administration au moins quinze jours avant la date de la réunion par une lettre recommandée avec accusé de réception comportant les faits lui imputés, il peut faire appel à une tierce personne pour assurer sa défense, il est obligatoire de mentionner dans la convocation que l'étudiant peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire auprès de l'administration de l'institut.

L'étudiant doit signer ce qui prouve qu'il a consulté son dossier disciplinaire ou, le cas échéant, qu'il en a renoncé volontairement.

Art. 21 - Les sanctions qui peuvent être prononcées par le conseil de la discipline sont :

- 1- l'avertissement,
- 2- le blâme,
- 3- l'interdiction de participer à une ou deux sessions d'examens,
- 4- renvoi de l'établissement pour une période maximale d'une année universitaire,
- 5- l'interdiction temporaire de l'inscription à l'institut pour une période maximale de deux années universitaires,
- 6- renvoi définitif de l'institut,
- 7- renvoi définitif de l'université,
- 8- renvoi définitif de toutes les universités.

Le directeur de l'institut peut, par une mesure administrative, interdire l'accès à l'institut à toute personne renvoyée au conseil de discipline et ce jusqu'au jour de sa comparution devant le conseil susmentionné.

Dans ce cas, le conseil de discipline doit se réunir dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la date du manquement ou de sa constatation ou de la date de l'interdiction de la personne en question d'accès à l'institut.

La sanction mentionnée au paragraphe 8 n'est exécutable qu'après approbation du président de l'université du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires religieuses.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 22 - Les ressources de l'institut sont composées des subventions accordées par l'Etat pour la gestion, la formation et la recherche, des subventions versées par les autres personnes morales publiques ou tout autre organisme, des legs et des dons, des recettes de l'exploitation de la propriété ou de leur cession conformément à la réglementation en vigueur, des recettes provenant des contrats de recherche, des études et d'expertises et des recettes provenant des contrats formation et des droits d'inscriptions et d'assurances et de tous les autres services lucratifs.

Les dépenses de l'institut sont composées des dépenses de gestion et des dépenses de développement soumises au visa du contrôle des dépenses publiques.

Art. 23 - L'exécution des recettes et des dépenses de l'institut se fait conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique et de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008 susvisée.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 24 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 août 2015.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Pour Contreseing

*Le ministre des affaires
religieuses*

Othman Battikh

Le ministre des finances

Slim Chaker

*Le ministre de
l'enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique*

Chiheb Bouden

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

Par décret gouvernemental n° 2015-1198 du 31 août 2015.

Les candidats dont les noms suivent, sont nommés au grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques :

- 1- Issam Anatar,
- 2- Mohamed Fethi Mlouka,
- 3- Dalel Toumi Azouz,
- 4- Rachida Abrougui,
- 5- Othman Braham,
- 6- Adel Jammazi,
- 7- Abderraouf Jaziri,
- 8- Saloua Kefi Khiari,
- 9- Chedly Ghazouani,
- 10- Chafik Ben Salah,
- 11- Nejiba Ben Abdelkader Missaoui,
- 12- Lotfi Romdhane,
- 13- Jalel M'kada,
- 14- Ridha Ghribi,
- 15- Abdelfattah Saïd,
- 16- Faiez M'sallem,
- 17- Hassouna Mersni,
- 18- Mounir Miladi,
- 19- Kamel Khalifa,
- 20- Mansour Hannech,
- 21- Jamel Boughariou,
- 22- Saïd Helal,
- 23- Ali Boughamoura.

Par décret gouvernemental n° 2015-1199 du 31 août 2015.

Les candidats dont les noms suivent, sont nommés au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques :

- 1- Mourad Zouari,
- 2- Moufida Chaouech,
- 3- Ali Hammami,

- 4- Tarek Ayoub,
- 5- Rakia Trabelsi Belkehia,
- 6- Nasreddine Chhibi,
- 7- Habib Hammami,
- 8- Kamel Hdhili,
- 9- Khaled Albanna,
- 10- Monia Albir Hammami,
- 11- Jalel Snoussi,
- 12- Imed Chakroun,
- 13- Tahar Mbarki,
- 14- Hkalifa Hammami,
- 15- Tijani Aljene,
- 16- Mohamed Salah Glayed,
- 17- Bechir Ben Rekaya,
- 18- Moez Hammami,
- 19- Moncef Tebbini,
- 20- Ibrahim Hajjej,
- 21- Imen Ghariani Sassi,
- 22- Othman Guerfala,
- 23- Kamel Chaâbene,
- 24- Nahla Ouni,
- 25- Hela Hassouna,
- 26- Abdelkader Fatnassi,
- 27- Mohamed Fadhel Ben Selma,
- 28- Lotfi Abdelli,
- 29- Kamel Jouini,
- 30- Soumaya Kaâbi Bouallagui,
- 31- Tahar Jaballi,
- 32- Khemaïs Boulares,
- 33- Moncef Bahri,
- 34- Mohamed Boufalgha,
- 35- Lamine Ben Hammadi,
- 36- Raja Benzarti Belhouane,
- 37- Mohamed Chamseddine Harrabi,
- 38- Nejib Fekih Hassen,
- 39- Mourad Arbi Mayel,
- 40- Mohamed Salhi,
- 41- Habib Chayeb,
- 42- Mohamed Habib Gazzah,
- 43- Habib Mabrouk,
- 44- Tahar Abdelkabir,
- 45- Chokri Ouji,
- 46- Mohamed Mouheddine Mabrouk,
- 47- Habib Zitoun,
- 48- Jaouhar Laâjimi,
- 49- Faïçal Jelassi,
- 50- Bisma Weslati,
- 51- Mehdi Khlass,
- 52- Fethi Sdiri,
- 53- Samir Bel Hadj Salah,
- 54- Salem Arfa,
- 55- Mahmoud Charfeddine,
- 56- Afef Farhat,
- 57- Ridha Belhaj,
- 58- Youssef Fallah,
- 59- Mohamed Kabadou,
- 60- Mohamed Ameer Kalai,
- 61- Haykel Hachlaf,
- 62- Samir Hadiaoui,
- 63- Mustapha Mechani,
- 64- Badr Dhahri,
- 65- Moncef Hermi,
- 66- Mohamed Sadri Ochi,
- 67- Zied Agueb,
- 68- Sassi Mahdhi,
- 69- Abdellatif Boutouta,
- 70- Habib Majdoub,
- 71- Kaïs Kefi,
- 72- Nadoua Gmir Dhaou,
- 73- Mohamed Naceur Souissi,
- 74- Rejeb Jbahi,
- 75- Leila Ben Dhiab Bendia,
- 76- Omar kaâbachi,
- 77- Fethi Hichri,
- 78- Jalel Rabhi,
- 79- Raoudha Khedher Bahri,
- 80- Abderrahmen Oualsi,
- 81- Abdelhamid Idoudi,

82- Rachid Ayadi,
83- Mohamed Lotfi Nacef,
84- Zouheir Melki,
85- Zouheir Badr,
86- Maâtoug Yahyaoui,
87- Hela Guidara Salmen,
88- Fraj Bahrouni,
89- Ridha Mejri,
90- Lotfi Saïdi,
91- Najet Snoussi,
92- Nouredine Lachiheb,
93- Tahar Smii,
94- Aïda Jeridi,
95- Hatem Ben Thameur,
96- Moujahed Bettibi,
97- Almandher Gaddour,
98- Abdallah Iftirich,
99- Zouheir Ben Meddeb,
100- Yazza Ben Soltana,
101- Mohamed Ben Chikha,
102- Mohamed Bouzidi,
103- Houcine Touil,
104- Kaâbachi Abid,
105- Mohamed Romdhane,
106- Maher Aouini,
107- Lazhari Limam,
108- Mohamed Salah Salmi,
109- Mourad Baklouti,
110- Mohamed Fahem Charfi,
111- Habib Ghabri,
112- Abderrazek Chihi,
113- Hedi Kadri,
114- Hassen Aloui,
115- Abdelkader Hajlaoui,
116- Kaïs Mensi,
117- Rebeh Riahi,
118- Ridha Beji,
119- Thouraya Ben Amor Ben Amor,
120- Chaâbene Moussa,

121- Monia Baccouche Ghanmi,
122- Aziz Sassi,
123- Hassen Nhaili,
124- Aloua Harrabi,
125- Mohamed Salah Medfaï,
126- Abderrazek Arfaoui,
127- Rachida Bouali,
128- Dalila Ibrahim Bouzid,
129- Adel Zriba,
130- Ghazi Chragua,
131- Nouredine Chayeb,
132- Ahmed Fitouri,
133- Nadia Farhat,
134- Foued Andoulsi,
135- Khalifa Gharbi,
136- Mongi Hammami,
137- Mongi Jaaïdi,
138- Fatma Mani Guen,
139- Khaled Lachtar,
140- Mohamed Charfi,
141- Jouda Msolli,
142- Mahdi Gaddoura,
143- Karim Bouali,
144- Khalil Bahloul,
145- Abdelbeki Abidi,
146- Meyess Allouch,
147- Wassila Yaâkoubi Hasnaoui,
148- Jamel Ben Rbah,
149- Sonia Maâtoug Ouzini,
150- Mongi Hadj Tayeb,
151- Othmen Hajd Salah,
152- Moncef Ghak,
153- Hejer Ben Dhiab,
154- Hayet Beltayef,
155- Ikbel Ben Hammouda,
156- Habib Ben Boubaker,
157- Rochdi Houcine,
158- Jamel Ferchichi,
159- Tayeb Jellali,
160- Mohamed Chebbi,

- 161- Sahbi Bedhiaf,
162- Mouhebeddine Boujlel,
163- Fethi Daghar,
164- Ahlem Jamoussi Chakroun,
165- Salem Khairreddine Ben Hassen,
166- Bechir Boubakri,
167- Mustapha Khmiri,
168- Omar Abboud,
169- Khemaies Ben Salem,
170- Chedli Boukraâ,
171- Abdelaziz Saâd,
172- Samir Haddad,
173- Abderrazek Lamine,
174- Moncef Ziadi,
175- Jalel Laârif,
176- Sassi Massaoudi,
177- Rafiaa Besbes Mabrouk,
178- Ahmed Khalfalli,
179- Moncef Meftahi,
180- Alahmadi Moumni.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Par décret gouvernemental n° 2015-1200 du 4 septembre 2015.

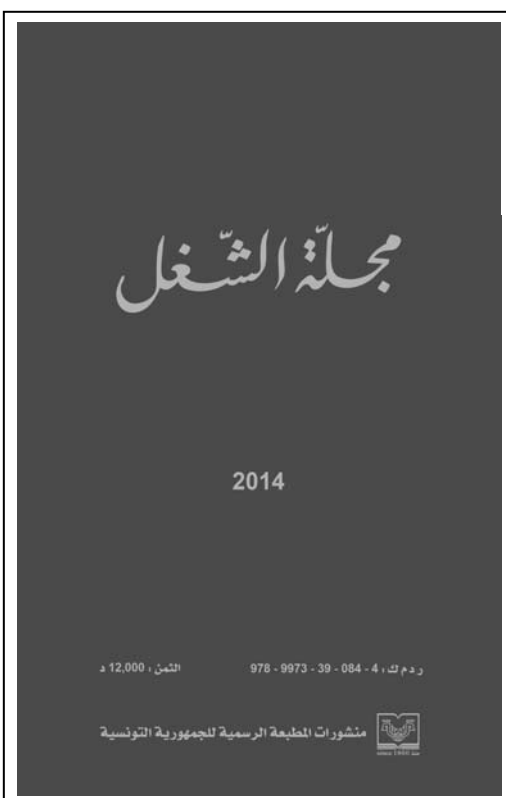
Monsieur Dhaker Baccouch est nommé président-directeur général de l'office national de la télédiffusion, et ce, à compter du 6 août 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1201 du 4 septembre 2015.

Monsieur Fethi Methnani est nommé directeur général du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications, et ce, à compter du 7 août 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1202 du 4 septembre 2015.

Monsieur Mohamed Ali Majeri est nommé directeur général du pôle technologique « El Ghazala des technologies de la communication », et ce, à compter du 7 août 2015.



منشورات : 2014

ردم ك : 4 - 084 - 39 - 9973 - 978

عدد الصفحات : 141

الحجم : 20 X 13

الثنى : 12,000 د

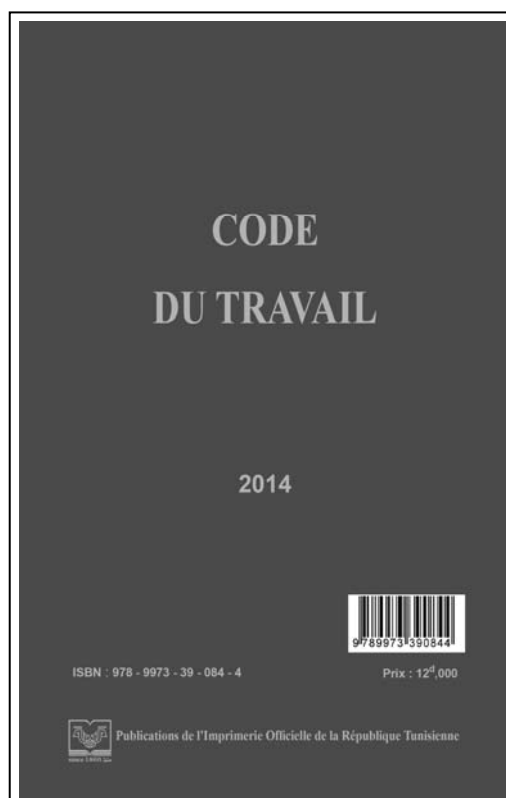
Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-084-4

Page : 178

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

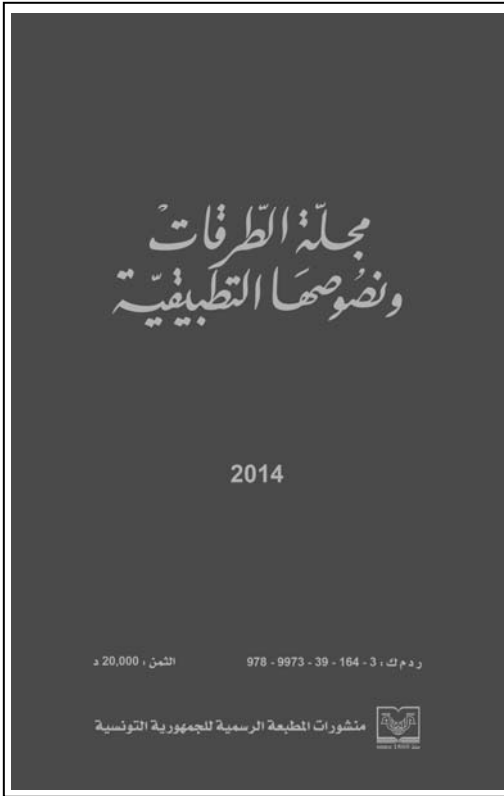


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثنى 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



منشورات : 2014

ردم ك 3-164-39-9973-978

عدد الصفحات : 484

الحجم : 20 X 13

الثنى : 20,000 د

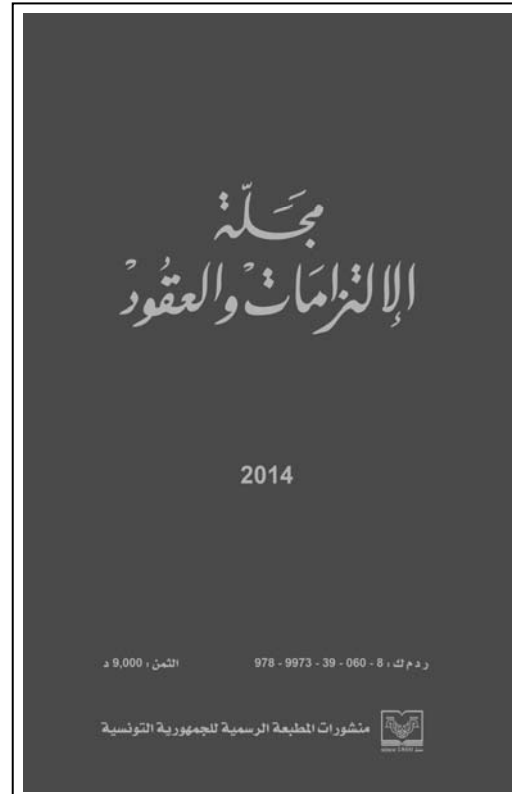
Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-060-8

Page : 253

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D

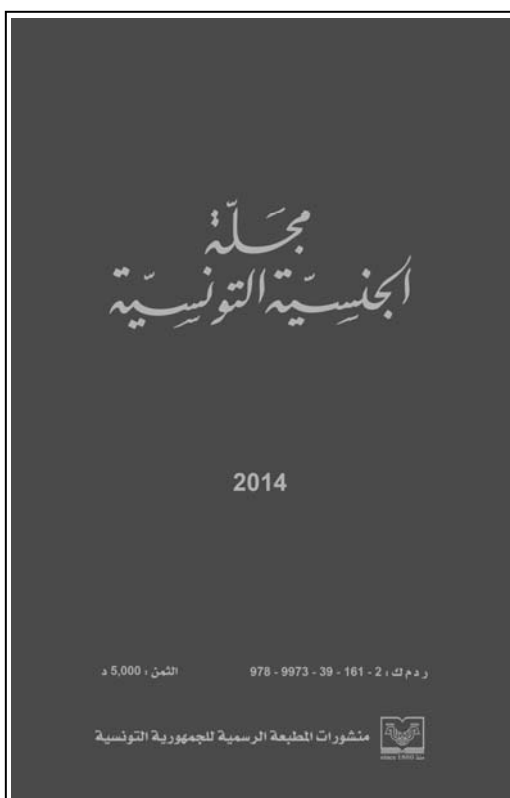


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثنى 500 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



منشورات : 2014

ر د م ك 2-161-39-9973-978

عدد الصفحات : 30

الحجم : 20 X 13

الثنى : 5,000 د

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-161-2

Page : 30

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثنى 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus